

JOSE ANTONIO RIOS GONZALEZ

MANUAL DE ORIENTACION Y TERAPIA FAMILIAR

(Enfoque sistémico teórico-práctico)

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE

2.3. Aspectos a controlar:

- 2.3.1. lo regresivo
- 2.3.2. lo "niño-niña"
- 2.3.3. la comunicación informativa
- 2.3.4. el troquelado simétrico
- 2.3.5. los modelos interactivos de la pareja 0
- 2.3.6. lo interactivo de la pareja S

2.4. Aspectos a eliminar:

- 2.4.1. los comportamientos sintomáticos
- 2.4.2. las fijaciones
- 2.4.3. la comunicación manipulativa
- 2.4.4. el troquelado de distanciamiento
- 2.4.5. la insatisfacción
- 2.4.6. los vínculos neuróticos y falsos

CAPITULO VII**DIAGNOSTICO DE LA DINAMICA FAMILIAR**

A los largo de los capítulos anteriores se ha hablado mucho de aspectos íntimamente relacionados con el diagnóstico. He preferido ir exponiendo algunos puntos que, al tiempo que intentaban clarificar estratos del grupo familiar, así como aspectos funcionales del mismo, sirviesen de pinceñadas que ayuden a comprender lo que hay que hacer con la familia para poder iniciar un trabajo de orientación o de terapia.

No obstante, parece obligado sintetizar en un capítulo específico cuanto se relaciona con el tema nunca agotado del diagnóstico de la dinámica familiar.

Conviene, sin embargo hacer una aclaración: en la terapia familiar no se separa lo que en otros modelos terapéuticos constituyen los niveles del diagnóstico y el nivel de tratamiento. A la familia se la diagnostica al tiempo que se la trata terapéuticamente. Diagnóstico y terapia van unidos y se realizan simultáneamente. Otra cosa es que por claridad metodológica y con fines didácticos, queden separado en éste y el próximo capítulo.

A fin de conseguir una mejor sistematización de cuanto deseo exponer, seguiré el siguiente orden:

1. Qué diagnosticar.
2. Cuándo y dónde diagnosticar.
3. Cómo diagnosticar.
4. Con qué diagnosticar.
5. Para qué diagnosticar.

1. Qué diagnosticar

Lo primero que hay que afirmar es que en el diagnóstico de la dinámica familiar que se defiende aquí prevalece el enfoque sistémico, tantas veces aludido. No se trata, por tanto, de una simple y mera recogida de información que suministren los miembros del sistema familiar. El enfoque clásico abunda en este aspecto: recoger el mayor número de datos para lo cual, en efecto, pueden ser necesarias varias sesiones de trabajo y de aplicación de pruebas al sujeto afectado por el motivo patente que desencadena la consulta. Tal modelo clásico se basa en un modelo médico que insiste, y es verdad, en que una buena historia clínica constituye un paso fundamental de cara a la curación del enfermo. Personalmente he dedicado muchos años a este modelo y en algún trabajo he dado cuenta de ello (RIOS GONZÁLEZ, 1963 f, 1965 a,b,c, 1968 e, 1971 a). Tal vez sea un aprendizaje que no debiera evitarse quien se inicia en el trabajo clínico, aunque posteriormente se adopte otra perspectiva.

La diferencia radical está en que el diagnóstico de la familia no se centra en un miembro de ella, ni para estudiar su estructura psíquica individual, ni para focalizar la acción posterior en sus conflictos, sino que pone su atención en el sistema total, en el estudio de la estructura de las relaciones que se establecen en el contexto familiar y en las que, indudablemente, participan e intervienen todos los miembros. Las palabras de MINUCHIN (1974) son claras en este sentido cuando afirma que "uno de los fines del proceso diagnóstico es el de ampliar la conceptualización del problema. La atención dirigida sobre un solo individuo que la familia ha elegido y conceptualizado como problema, debe ampliarse hasta comprender las interacciones que la familia tiene en su actual contexto" (pag. 131, ed. italiana), siendo él quien da una descripción de lo que es el concepto de diagnóstico en este sentido al decir que consiste en una "acomodación del terapeuta a la familia con el fin de constituir un sistema terapéutico que se desprende de la valoración de sus experiencias de la interacción de la familia en el momento presente" (id., p. 130), lo cual y junto al carácter de no limitación a un sujeto, tampoco tiene en cuenta el pasado de menos de una manera absoluta. Se tiene en cuenta la influencia del pasado de los miembros en la formación del síntoma, así como debe tenerse muy en cuenta la influencia de los mismos en el mantenimiento de los síntomas que se contemplan en el momento actual.

De tal modo, de contemplar la realidad a diagnosticar se derivan los siguientes aspectos, siempre según la línea trazada por MINUCHIN (1978) y a cuyas páginas se refieren los paréntesis:

- Mira al paciente en el contexto (p. 16 ed.ital.)
- No sólo describe los conflictos del paciente con su contexto, sino que los considera significativos para su posterior terapia (p.16).
- Delinea y abre al tratamiento terapéutico los aspectos del comportamiento de los miembros de la familia que obligan al paciente a mantener un determinado síntoma (p.15-16).
- En vez de concentrarse sobre la vulnerabilidad psicológica o fisiológica del paciente tomado aisladamente, se mira a éste en su contexto familiar (p.55).
- La unidad de estudio y predicción no puede ser sólo el paciente, sino el modelo transaccional (p.55), la persona y su entorno como una unidad integrada, lo que viene demostrado cuando se observa que al cambiar el contexto o el grupo, cambia el paciente.
- Aparece, por tanto, la necesidad de observar las transacciones interpersonales y el *cómo* y en *qué* medida determinan la gama de los comportamientos de cada miembro de la familia (p.17).
- "No más el estudio del hombre independientemente de sus circunstancias el hombre héroe-. Es necesario hacer un estudio que permita sustituir una visión del hombre como ser influido por un contexto" (p.17).
- La unidad psicológica no es ya el individuo, sino el individuo en sus contextos sociales más significativos" (p.26).
- El comportamiento individual es el resultado de un movimiento circular de partes que se influyen mutuamente (p.26), de modo que tal comportamiento es simultáneamente "causado" y "causante", al tiempo que cada parte del sistema debe ser considerada como "organizante" y "organizada" respecto a otras partes (p.26).
- La acción de una parte es, simultáneamente, la interrelación de otras partes del sistema, lo que lleva a que el sistema pueda ser activado en un determinado número de puntos o secuencias, constituyendo verdaderos mecanismos de "feedback" (p.26).
- Un modelo como el sistémico postula que ciertos tipos de organización familiar están estrechamente correlacionados con el desarrollo y mantenimiento de síndromes psicosomáticos en los niños, y que los síntomas de éstos, a su vez, juegan un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis familiar (p.26-27).

- Por lo mismo, y este aspecto hay que destacarlo para una mejor comprensión del trabajo posterior, los síntomas deben ser definidos no sólo como comportamientos de un miembro de la familia, sino de la interrelación de todos los miembros de la familia (p.27).
- De ahí se deriva que este modelo afirme también la importancia de la experiencia psicológica de cada miembro de la familia (p.17).
- Lo importante a destacar en el diagnóstico de la dinámica familiar es la continuidad de las influencias de los miembros del sistema total en la formación y mantenimiento del síntoma.
- Por ello no hay necesidad de insistir en la causas históricas -el *por qué* de un síntoma-, sino en el uso que se hace del mismo en el momento presente -el *para qué* del síntoma-.

Se trata, por tanto, de diagnosticar cómo funciona la familia en función de un síntoma que se destaca en el dinamismo del sistema.

Y su descubrimiento como mecanismo circular e interactivo es ya un elemento básico de la acción terapéutica.

Una segunda consideración acerca del *qué diagnosticar* se centra en aspectos concretos sobre los que hay que insistir en el contexto de lo que vamos a llamar primera entrevista con la familia.

Teniendo en cuenta las aportaciones de MINUCHIN (1974) y las sugerencias de STIERLIN (1980), parece que puedan fijarse como objetivos a diagnosticar los siguientes:

Según MINUCHIN, y de ellos se habló ya en otro lugar, los principales sectores del diagnóstico de la interacción de la familia, son éstos:

1. La estructura de la familia.
2. La flexibilidad del sistema.
3. La resonancia del sistema familiar.
4. El contexto ambiental de la familia.
5. El estadio de desarrollo y la puesta en práctica de lo propio del mismo miembro por miembro.
6. Los modos a través de los cuales los síntomas del paciente designado se usan dentro del sistema familiar para mantener los modelos transaccionales preferidos por la familia.

Para H. STIERLIN los objetivos del diagnóstico que ha de abordarse, son:

1. Diagnosticar sistemáticamente la familia para elaborar una hipótesis dinámica relacional.
2. Comprender la situación motivacional de la consulta.
3. Motivar a toda la familia para que realice una terapia familiar mediante las tareas de:
 - reducir miedos
 - dar confianza
 - reducir vergüenzas
 - dar esperanza

A ello añade otros dos objetivos que refuerzan una vez más la idea de que, en este tema, diagnóstico y terapia son niveles inseparables de una misma realidad:

4. Establecer un contrato terapéutico.
5. Preparar una terapia posterior.

Teniendo en cuenta cuanto se desprende de lo anterior, mi esquema de trabajo con las familias se estructura en torno a varios puntos sobre los que centro la atención a fin de conseguir una "idea de la familia" para actuar sobre ella.

Áreas de cambios

Una vez definido el problema que desean consultar, es necesario replantear la cuestión mediante lo que viene llamándose "redefinición" del problema. Consiste en hacerles ver que el cambio deseado ha de ir en otra dirección diferente a la que ellos preven. Este enfoque permite analizar las características del sistema familiar en cuanto que alguna o algunas de ellas tienen que ver con el conflicto consultado.

Aunque en cada familia encontramos múltiples características necesitadas de replanteamientos más sanos, pueden señalarse algunas áreas especialmente necesitadas de este trabajo: sistemas de interacción, mensajes (tanto en sus contenidos como en su relación), ya sean verbales o no verbales (símbolos, gestos, modales, tonos de voz, poder, dinero...), tipos de comunicación.

Áreas a diagnosticar

Especialmente en lo relativo a la ampliación del campo diagnóstico. Se trata, por tanto, de ir más allá del sujeto designado como paciente, para contemplarlo como una parte de un sistema permanentemente interactivo, lo que obliga a incluir al individuo con su familia, sus profesores, su estructura escolar, etc... (RÍOS GONZÁLEZ, 1983 b,f,g). En tal sentido es necesario establecer una relación entre ciertas áreas y lo que se ofrece como comportamiento necesitado de orientación o terapia. Cuanto se ha expuesto al hablar de la estructura del S.F.O. y de la actitud ante el mismo, tiene aquí su lugar concreto de valoración y diagnóstico: valores, poder, mitos, tabúes, etc... (capítulo V).

Dinámica familiar

No solo en su estructura o elementos que intervienen en ella, tales como los miembros del sistema familiar propiamente dicho o personajes significativos en ese sistema familiar concreto, sino modos de interacción y comunicación. En ello intervienen fenómenos que se han analizado en otras páginas anteriores, tales como existencia de dobles vínculos, triángulos perversos, reglas y sus clases, fidelidades ocultas, así como el juego manipulativo de los síntomas, la persistencia de ritos y rituales, el ejercicio del poder, la autoridad, los tipos de disciplinas y la presión de las actitudes educativas parentales, sin olvidar los intercambios sanos o inadecuados que se establecen a partir de la estimación del paciente designado en cuanto "ser competente en...", "ser valioso en...", "ser querido en..."

Un puesto destacado en la interacción lo ocupa el tema de los mensajes, tanto en el nivel de sus tipos (mensajes de contenido y de relación) como en el del modo de ser enviados (circularidad continua, inevitable verbal/no-verbal, tanto sana como disfuncional y hasta patológica).

Comportamientos

Ocupa un lugar importante la distinción entre comportamientos afectuosos y por tanto, potenciadores de estabilidad, cohesión y progreso personal y sistémico, y los comportamientos restrictivos o necesitados de cambios inmediatos. Igualmente hay que destacar en este apartado la posibilidad que ofrece el sistema familiar para la conquista y desarrollo de comportamientos autónomos, individualizados, acordes con la personalidad peculiar de cada miembro. Todo ello está muy vinculado al grado de riqueza afectiva que se potencia en la familia.

por lo que se hace necesario un continuo esfuerzo para la superación de los comportamientos rígidos que bloquean y taponan la creatividad personal de los miembros.

Un tema especial: el quintacolumnista

En todo conflicto familiar se oculta un factor cuyo descubrimiento constituye una pieza clave para su adecuada solución: la existencia de un miembro-quintacolumnista que, de alguna manera, refuerza y hace posible la persistencia de un síntoma perturbador. Se encierra en tal figura una aparente contradicción, dado que, por una parte, se busca una solución al problema, mientras que por otro se hace "algo" para que la situación no cambie. La raíz de tal paradoja se centra en que de lo que se padece se beneficia algún miembro, a través del ya conocido fenómeno del "beneficio secundario" o "neurótico" que está presente en cualquier sintomatología.

No es tarea fácil la de descubrir a este miembro quintacolumnista, pero es posible localizarlo. Su diagnóstico hay que hacerlo a través del hallazgo de pistas indicadoras de un cierto apoyo, justificación, racionalización de cuanto está aconteciendo en la familia. Gracias a estos mecanismos, ese miembro obtiene algún tipo de ventaja, aunque algunas veces sea tan pobre como la de poder realizar de este modo un papel en la vida del miembro sintomático, ya sea como protector, padre o madre amparador, receptor de estima o valoración, sin olvidar los aspectos más sutiles mediante los cuales el quintacolumnista adquiere ante los ojos del paciente designado un halo de figura que le entiende, comprende y defiende.

Es un punto que, de no ser descubierto, se convierte en verdadero obstáculo para la adecuada evolución de un problema materializado en la sintomatología de un miembro.

Estos aspectos pueden quedar integrados dentro de lo que podemos denominar diagnósticos del contexto sistémico en cuanto de la relación de unos elementos con otros aparecerá un determinado tipo de familia sobre el que habrá que actuar a partir del momento en que se verifique el primer contacto, la denominada primera entrevista en la que ya hay terapia aunque la exploración de los puntos señalados sea un objetivo prioritario.

2. Cuando y dónde diagnosticar

Una idea común en todos los terapeutas de la familia es que lo que viene llamándose la primera entrevista es una pieza clave para la terapia basada en un buen conocimiento de la dinámica familiar.

Esta Primera Entrevista Familiar (P.E.F.), no obstante su aparente simplicidad, comprende varios aspectos que me parece oportuno distinguir.

- a. Su metodología
- b. Criterios prácticos para su realización.
- c. Técnicas a utilizar.
- d. Mi esquema de P.E.F.

Veamos cada uno de ellos separadamente.

a) Metodología de la primera entrevista familiar

Ha de plantearse en función de lo que es la verdadera Terapia Familiar, tal y como se entiende en el enfoque sistémico y relacional. Aunque ya se ha dicho y se ampliará más en el último capítulo, los fundamentos se toman de la Teoría General de Sistemas (T.G.S.) aplicada al análisis de la dinámica familiar.

Hay que advertir, sin embargo, que la P.E.F. difiere en algunas cosas de lo que es una entrevista en términos clásicos. Señalo las diferencias más importantes:

1. Se entiende por P.E.F. no sólo una sesión de trabajo con la totalidad del sistema familiar, sino que tras su enunciado se encierra la serie más o menos prolongada de contactos que permiten establecer las coordenadas sobre las que se trazará el trabajo terapéutico con ese sistema familiar.
2. Hay, en efecto, una primera entrevista o primer encuentro que tiene unos objetivos delimitados con un final igualmente concreto: los *objetivos* son los derivados de la necesidad de obtener aquellos datos que permitan hacer el planteamiento de futuras actuaciones sobre la familia; abarca lo dicho en el apartado anterior (qué diagnosticar). *El final* se articula en torno a los pasos a dar, el ritmo de trabajo con la familia, quiénes han de participar y cuanto abarca el tema del contrato terapéutico, como se verá en su lugar.
3. Por ello distinguo entre *primer encuentro* y *primera entrevista*, dado que tienen ámbitos distintos, aunque el primero quede incluido en la segunda.

4. Es una idea también común la de admitir que el diagnóstico y la terapia familiar se inician con el primer contacto telefónico. En el apartado d (mi esquema de P.E.F.) me referiré a un modelo de ficha en el que se recoge lo relativo al primer contacto telefónico.
5. La P.E.F. toma en cada autor una forma distinta, aunque todos coinciden en algunos elementos comunes. Esta diversidad depende del enfoque que pretenden dar a la integración o diferenciación más o menos clara entre diagnósticos y terapia de familia que se atiende en consulta.
6. Personalmente mantengo que con la familia no hay que establecer esta distinción de una manera tajante. Ya desde el primer encuentro hay tareas de diagnóstico, así como en la misma hay tareas terapéuticas que se ponen en funcionamiento. La experiencia de cada día refuerza esta idea.
7. Fácilmente se deduce que en la P.E.F. no hay aplicación de pruebas o tests de cualquier tipo. Tampoco se da entrada a un trabajo unilateral sobre el miembro señalado como paciente. Se actúa sobre toda la familia, no sólo a través de la verbalización, sino utilizando métodos activos y dinámicos que pongan en juego las interacciones sobre las que se pretende actuar a partir de este momento.
8. En la P.E.F. hay que establecer las bases para realizar unos cuantos pasos en el trabajo directo con la familia. Así, por ejemplo, resulta imprescindible tener muy claro que el "esquema lineal" clásico ha de ceder su puesto a lo que puede denominarse "esquema circular retroalimentador".
9. Los pasos a dar desde este primer momento, quedan sintetizados en los siguientes:
 - Pasar del individuo al sistema.
 - Pasar de los contenidos a los procesos.
 - Pasar de interpretar a prescribir.
 - Pasar de buscar orígenes a comprender pautas.
 - Pasar de analizar síntomas a analizar los mensajes implícitos en tales síntomas.
 - Y pasar de indagar causas (etiología clásica según un modelo médico psiquiátrico) a reestructurar modelos de interacción.

b) Criterios prácticos para su realización

Los que regulan el trabajo habitual que realizo con las familias, pueden sintetizarse así:

1. Trabajar con material móvil en una sala amplia donde cada miembro de la familia pueda elegir con libertad el lugar que prefiera. Para ello utilizo sillones-módulos que puedan moverse y ser desplazados si fuera el caso.
2. No indicar a ninguno el lugar que deben ocupar. Cuando entran en la sala no hay nadie ni existe ningún sillón de mayor o diferente rango, ya que si fuese así y alguna vez lo he visto al tener que usar una silla diferente al resto- suele dejarse o para el miembro más importante de la familia o para el terapeuta que los atenderá.
3. Es importante ver cómo se sientan los miembros de la familia: cómo quedan distribuidos en el espacio y en torno a quién o quiénes se agrupan los demás.
4. El punto anterior es importante puesto que en base a ello puede hacerse una hipótesis inicial respecto a la existencia o no de alianzas, coaliciones, miembros aislados o periféricos, etc. Igualmente el terapeuta puede realizar algunos cambios jugando con el espacio físico de la sala, cambiando de lugar a alguno o cambiándose él con aquel miembro que interés desplazar en un momento dado. La presencia de un coterapeuta -modalidad que adopto habitualmente- permite una mayor flexibilidad en estas operaciones. También es importante ver qué sillón dejan libre para el terapeuta y coterapeuta: dónde lo sitúan, entre quiénes, al lado de quién... etc.
5. El terapeuta, y a partir de esta situación, puede jugar con la familia todo el profundo tema de crear alianzas, reforzar coaliciones, destruir triángulos perversos, romper simbiosis, evitar hiperprotecciones, integrar miembros periféricos, controlar intrusiones, establecer canales de relación y comunicación. Todo ello facilita la construcción del *mapa emocional de la familia* como pieza sobre la que asentar nuevas intervenciones.
6. Sobre el manejo del espacio se van a asentar las estrategias de cambio, resistencia al cambio, reacciones ante los cambios, así como las de proximidad emocional, cercanía emotiva, etc., técnica que permite descubrir interacciones que no sería fácil hacer patente mediante las simples técnicas verbales.

7. El primer encuentro tiene unos momentos especialmente significativos a los que deseo aludir aquí. Su desmenuzamiento didáctico no indica rigidez en su realización, sino deseo de clarificar cuanto incluye y supone. Una característica fundamental del trabajo con las familias es la agilidad que hay que imprimir a los encuentros con la misma, al tiempo que intentar lograr una mezcla equilibrada de lo espontáneo y lo necesitado de rigor para no caer en una charla de café.

Estos momentos significativos pueden ser los siguientes:

- a. *Quién inicia* la exposición del motivo que los trae a la consulta.
- b. *Cómo comparten* los otros tal exposición: acuerdos, desacuerdos, reformulación del motivo.
- c. *Reacción ante tales reacciones* de los otros miembros: empatía, hostilidad, rechazo, alianza, asentamiento, indiferencia, crítica a la reformulación hecha.
- d. *Mentalidad del S.F.* ante el problema y *nivel de comprensión* del mismo S.F. de la situación motivacional que los trae.
- e. *Motivación de todos* para trabajar problemas comunes del S.F. una vez que capten que hay que pasar del paciente designado al sistema familiar total.
- f. *Formulación del motivo* hecha por el propio paciente designado.
- g. *Soluciones intentadas* hasta el momento de esta nueva consulta, y grado de eficacia de las mismas. En caso contrario: qué alternativas se han intentado, quién las propuso, por qué no se ejecutaron y quién/ quiénes colaboraron y/o las rechazaron.

Un punto importante a destacar en este primer encuentro es el de:

- h. *Qué esperan obtener* de la T.F. con una clara *definición del cambio* o cambios que desean alcanzar.

En medio de este conjunto de maniobras a poner en práctica, empiezan a delimitarse aspectos que conducen a la formulación de algunos *cambios iniciales* en la línea de lo que viene denominándose Cambio-2, frente al Cambio-1 que se busca en los tratamientos clásicos.

Es importante destacar algunos puntos-aje que permiten conocer mejor a la familia con que inicia el trabajo de orientación o terapia. Por ejemplo:

- *Mapa de comunicaciones transaccionales.*
- *Reacciones sistémicas centradas en:*
 - quién interrumpe a quién
 - cuándo interrumpe
 - en qué temas interrumpe
 - quién domina la situación
- *Comportamientos sintomáticos* presentes en la familia y no sólo en el P.D., con distinción clara de:
 - síntomas antiguos y persistentes (AP)
 - síntomas antiguos y temporales (AT)
 - síntomas recientes (R)
- *Relación significativa a través del síntoma:*
 - vinculación del/de los síntomas a factores personales, ambientales situacionales, etc.
 - no intentar responder a la pregunta "por qué" tal síntoma, sino conducir a la familia a que enfrente la búsqueda de una respuesta al interrogante "para qué" tal síntoma.
- *Delimitación entre síntoma/síntomas propios del P.D. y síntomas existentes en el S.F.* bajo mil formas camufladas y, por lo mismo, descargadas de ansiedad y tensión.
- *Delimitación de un síntoma central al S.F.* y en torno al cual giran otras muchas cosas que prefieren ignorarse o tapadas por alguno o algunos miembros del S.F. Esto obliga a una *tarea de desafío* por parte del terapeuta para provocar una crisis que facilite el paso del P.D. al sistema.
- Determinación, en cuanto es posible, de los *comportamientos sintomáticos* existentes en el S.F. como totalidad, con lo cual se habrá realizado el paso indicado anteriormente. Cuanto se ha dicho en el capítulo 6 al hablar de las familias sintomáticas, tiene qué una aplicación que facilita tal determinación.
- Descubrimiento de los *factores sistémicos influyentes*, entendiendo por tales aquellos elementos personales, de ambiente o de situación que:

- a) o son causa desencadenante de la aparición de un comportamiento, síntoma, conflicto o problema.
- b) o son causa reforzante que contribuye al mantenimiento del síntoma, problema, etc.

• E. P.D. ha de ser visto a la luz de estos criterios:

- a) comportamiento sintomático prevalente
- b) comportamiento provocatorio del S.F.
- c) grado en que atrapa a otro/otros: a quién o a quiénes y para qué (beneficio secundario del síntoma)
- d) poder ejercido por el síntoma y gracias a él
- e) capacidad para expresar las propias necesidades
- f) capacidad para captar las necesidades de los otros: cuáles y quiénes.

c) Técnicas a utilizar

El nivel de técnicas a utilizar se entrecruza con el de las tácticas y estrategias, todo lo cual constituye un amplio capítulo en el que no hay más remedio que seleccionar. Expongo lo que constituye en el momento actual un conjunto central de técnicas tal y como vengo trabajando en la terapia familiar y en su diagnóstico interaccional.

1. *No preguntar directamente a nadie al iniciar la entrevista con toda la familia; hacerlo de un modo tan neutro que impida canalizar de modo selectivo un tipo de planteamiento que la familia o algún miembro intuya como más valioso o aceptado por parte del terapeuta o terapeutas. Por ejemplo:*
 - "¿Qué les pasa o preocupa?"
 - "¿Qué ha hecho que pidan Vdes. una consulta?"
 - "¿Qué ha desencadenado la necesidad de acudir a alguien que les escuche?"
 - "¿Qué les preocupa en estos momentos?"
2. *Observar los lenguajes no-verbales: posturas, movimientos, sonrisas, miradas evasivas o buscando apoyo, aprobación o refuerzo, movimientos de las manos, agitación de cualquier tipo, distensión...*

3. Si la familia o alguno de sus subsistemas tiende a centrar toda la verbalización del programa en un sintoma del P.D., llevarlos hacia la contemplación de *si existen o no otros síntomas* en otros miembros o en todo el S.F., ya sea bajo forma de mitos, ritos, defensa de valores, tabúes, etc...
4. *Construir* lo antes posible el "mapa emocional de la familia", utilizando como material para ello:
 - a) la colocación física que han adoptado en la misma sala de Terapia
 - b) los canales de interacción comunicativa tal y como van expresándose "aquí y ahora", con la exploración de si lo que sucede "ahora" "aquí", es lo que suele suceder en la vida ordinaria de la familia.
5. Utilizar complementariamente al "mapa de la familia" lo que vengo denominando "el plano de la vivienda" y "la sala de estar en casa" como se expone al hablar de "cómo diagnosticar".
6. *Limitar* cuanto sea posible la verbalización explicativa de lo que sucede en la familia y sus situaciones para dar paso preferente a "hacer lo que sucede". He visto a MINUCHIN canalizar las verbalizaciones hacia realidades concretas. El lo expresa de un modo muy gráfico: "No me diga Vd. cómo baila. Baile" Traducido a cuanto deseo destacar aquí es idéntico a esto:
 - Dirigiéndome al padre: "No me diga Vd. qué le aconseja o dice a su hijo. Hable ahora, aquí, con él para que yo vea cómo lo hace".
 - O a un adolescente: "No me digas en qué te gustaría que cambiase tu madre. Mira, la tienes aquí, muy cerca: habla con ella y dile lo que quieres que cambie. Tal vez no te lo ha oído nunca".
 - O a una madre angustiada: "Comprendo lo mal que lo pasa Vd. Pero si me lo dice a mí a lo mejor avanzamos muy poco. Hable aquí y ahora con su hija para que vea lo que Vd. desea y espera de ella"
7. De este modo empiezan a establecerse nuevas interacciones comunicativas en niveles que muchas familias tienen descuidados o, incluso inexplorados, porque no saben, no pueden o no quieren. *Crear ese momento* en la misma sesión de T.F. es un gran avance.

8. *Establecer límites entre subsistemas o generaciones* para lo cual, como se ha anticipado ya en otros lugares, vale el manejo del espacio, de tal modo que colocando a los de un mismo subsistema en una sala de terapia, infantil, los hijos-riños de los hijos-adolescentes, así como cualquiera de estos del mundo propio de los padres/adultos. Así captan cómo hay dos planos diferentes de cuya defensa y mantenimiento dependen la adecuada o inadecuada realización de procesos emocionales que contribuyen a la maduración del individuo. Resultaría difícil y lento explicar este contexto evolutivo. Cuando lo ven realizado en la misma sesión lo captan. Y, sobre todo, lo ven referido a ellos mismos porque se realiza con ellos mismos.
9. *Hacer que la primera entrevista se convierta ya en una verdadera sesión de Terapia Familiar*, no limitando la acción del terapeuta a simples exploraciones sobre aspectos de la dinámica familiar. Parte de la habilidad del terapeuta reside en saber elegir desde el primer momento algunos aspectos o áreas concretas sobre los que se marquen acciones con finalidad terapéutica, de tal modo que al final de la sesión se hayan iniciado cambios mediante alguna estrategia de las que se hablará en el próximo capítulo.

d) Mi esquema de P.E.F. (Primera Entrevista Familiar)

Basado en la experiencia realizada hasta el momento presente, y teniendo en cuenta elementos útiles derivados de las sugerencias de otros expertos en el tema, mi actual esquema de trabajo se estructura en torno a los siguientes puntos:

1. El primer contacto telefónico
 2. El contacto directo con la familia entera
 3. La sesión de T.F. con su correspondiente registro de datos.
- Veamos cada uno de ellos por separado.

1. El primer contacto telefónico

Cualquier terapia de la familia con cierta experiencia, parte de la idea que la verdadera terapia familiar comienza con la primera llamada telefónica. Tal llamada inicia una relación que debe ser entendida desde sus primeros momentos como relación terapéutica. Por ello tiene su sentido, que va más allá

de la mera recogida de datos fríos sobre la persona que sufre determinadas alteraciones y se define como "paciente" necesitada de atención especializada. El verdadero sentido está en ofrecer a la familia de tal paciente, un encuadre terapéutico en el que capten cómo trabajamos con ella y cuáles son las coordenadas en torno a las que ellos mismos han de adoptar una actitud igualmente terapéutica.

El actual modo concreto de proceder en "Stirpe" toma la siguiente forma de actuación

a) Ficha del primer contacto telefónico (1)

Recibida la primera llamada, la persona que la recibe -ordinariamente la Secretaría del Centro- completa los siguientes datos:

1. Paciente designado: Nombre completo y edad.
2. Estudios o profesión.
3. Lugar que ocupa en la serie de hermanos y número de hermanos vivos.
4. Domicilio postal y teléfono de contacto con la persona que realiza esta primera llamada.
5. Quién envía o aconseja que consulten con nosotros.
6. Motivo inicial que provoca la consulta.
7. Quién llama o pide la consulta.
8. Fecha de esta primera llamada. Quién la recibe en nuestro Centro.
9. Estructura de la familia: Nombres (padre, madre, hijo 1º, 2º, 3º, 4º, etc...), edad, profesión/estudios de cada cual y observaciones que aporten al proporcionar tales datos.
10. Breve síntesis del planteamiento que hace la persona que llama y pide la consulta tal y como la capte quien la recibe.
11. Miembros que se citan para la primera sesión de familia.
12. Citados para el día, mes... y hora.
13. Serán recibidos por...

Interesa comentar algún punto de los anteriormente señalados:

Quién envía o aconseja que consulten. Con ello se trata de averiguar el origen de la motivación, dado que con excesiva frecuencia se consulta bajo algún tipo de presión derivado del prestigio de quien indica la conveniencia de someterse a

(1) Ver también ficha FTG, pág. 541-546

estudio una situación. No voy a detallar aquí el grado de incidencia con que tal consejo viene dado por un profesional cualificado (psicólogo, orientador escolar, tutor, profesor, médico pediatra, psiquiatra, etc.) o por alguna persona con algún grado de influencia sobre esa familia concreta (asistente social, sacerdote, familiar con peso específico en la familia) o persona anteriormente tratada por nosotros que, por alguna razón, conoce esta nueva situación.

Nuestra actual preocupación respecto a este punto está en la necesidad de plantear la posibilidad de que quien aconseja venir a T.F. venga también a la consulta. Es la idea ya expuesta en otro lugar de que no basta ver al "señalado" (P.D.), sino ver junto a éste al "señalante", especialmente cuando se trata de alguna de las personas indicadas en las dos primeras categorías (profesional cualificado y persona influyente en la familia). La idea básica que respalda este intento es el convencimiento -demostrado por la experiencia- de que si no se hace así, hay un área de "poder" que permanece fuera del contexto terapéutico con evidente influjo que puede invalidar y descalificar la acción de los terapeutas de la familia. Baste aludir al simple hecho de que la persona "enviante/señalante" pide a la familia una cierta información sobre lo que nosotros hemos dicho, hecho, opinado y aconsejado. Y ante tales datos esa persona adopta una actitud que se transforma en "confirmación" de nuestra intervención terapéutica o en "descalificación" más o menos clara de la misma. En resumen: nuestra acción vendrá valorada fuera del propio contexto terapéutico.

En estos momentos trabajamos más directamente este objetivo, aunque hay que decir que la resistencia es muy fuerte, aunque no diferente a la que las mismas familias ponen cuando reciben la información de que queremos verles a todos y no sólo al P.D.

Quién llama o pide consulta. Con este dato llega a conocerse quién ostenta en un sistema familiar un grado de poder que es preciso detectar al iniciar el trabajo. Ordinariamente es la madre, lo que corrobora que en las áreas relacionadas con lo psíquico, educativo, escolar, y en general, la salud mental, es la madre la que recibe una "delegación" familiar que configura la dinámica en lo relativo a posesión de información, poder, centralización de tareas, etc.

Teniendo en cuenta cuanto se ha expuesto al hablar del "poder" y del papel de la madre en la orientación y terapia, este dato interesa resaltarlo desde el primer momento que tenemos información sobre una familia.

Tarea del terapeuta es confirmar en los contactos sucesivos si las conclusiones derivadas de esta hipótesis son correctas o no, encontrando ahí un filón sobre

el que asentar algunas intervenciones que se desarrollarán a lo largo de toda la T.F.

Fecha de la primera llamada y quién la recibe. Respecto a la fecha del primer contacto telefónico, únicamente interesa a fin de ver cómo es cierta la afirmación de M. SELVINI, según la cual es erróneo conceder una entrevista de urgencia. Personalmente, y según mi experiencia, añadiría algo más: un período de tiempo entre la primera llamada y el primer encuentro, ayuda a tomar conciencia de que lo que se va a empezar tiene un contexto inusual y fuera de los modelos clásicos, aparte de facilitar que en tal período reciban alguna información complementaria de gran utilidad, tal y como se verá enseguida.

Es importante que este tiempo se aproveche para algo relacionado con la misma construcción del "contexto sistémico" en que vamos a encontrarnos con la familia entera. Por ello, si se les dirá en qué fecha serán recibidos (punto 12 de la ficha telefónica), advirtiéndoles en ese momento que antes de venir recibirán unas normas de cómo trabajamos y que en una hora/día que se acordará con cierta aproximación, la misma persona que pide la consulta recibirá una llamada de uno de los terapeutas que los recibirán, para completar los datos que se le han pedido en este primer momento.

Nuestro modo de trabajar nos lleva a implantar que el coterapeuta conecte ya con la familia a través de esta nueva llamada que se hace desde nuestra consulta. En ella, aparte de confirmar toda la información recibida en la primera, se explica con más detalle nuestra metodología y con un tono que tratamos incorporar algo más que lo que puede tener de frío y administrativo la compilación de una ficha. El coterapeuta actúa ya como definidor del contexto sistémico, insistiendo en algunos datos que son importantes: queremos ver a todos los de la familia, éste es nuestro modo de trabajar para tener una visión completa de cómo vive el P.D.; serán recibidos por dos miembros del equipo cuyos nombres se les proporcionan al mismo tiempo que nosotros tenemos los de cada miembro de la familia; se les advierte que tras el espejo unidireccional hay otros miembros del equipo que nos ayudarán a quienes estemos directamente con ellos y podrán intervenir en la sesión mediante un teléfono y para grabar en magnetofón las sesiones que tengamos.

El fondo de la información intercambiada en esta segunda llamada servirá de punto de apoyo para que antes de recibir a la familia pueda establecerse una hipótesis sobre la que empezar a trabajar con la familia. Obrar de otro modo será, como mínimo, perder el tiempo. Es aquí donde aparece especialmente

luminosa la idea de M. SELVINI (1980) cuando hace ver que de no tener una hipótesis coherente con la epistemología sistémica adoptada, podría darse la impresión de que las intervenciones durante o al final de la sesión salen por arte de magia, cuando en realidad corresponden al desarrollo correcto de algunos principios establecidos sobre la información recibida.

Toda esta información recogida por un coterapeuta se convierte en material de trabajo en la pre-sesión que celebramos los terapeutas que intervenimos en una terapia familiar y aquellos otros miembros del equipo o personas en formación que verán la sesión detrás del espejo. El replanteamiento de las hipótesis está previsto mediante la formulación de otras alternativas basadas en los datos obtenidos en esta llamada previa.

Quién recibe a la familia. Siguiendo nuestro esquema, la familia es recibida por dos terapeutas, uno de los cuales ya ha establecido contacto con la familia mediante esa llamada telefónica que completa los datos de clasificación y burocracia que se obtienen en la primera.

Esto facilita que la presencia en la sesión de un segundo terapeuta no se perciba como una intromisión o la presencia de un espectador callado o menos activo que el que lleva la sesión. En el capítulo próximo se hablará de la coterapia como método de trabajo y allí quedarán aclaradas algunas cosas. Es conveniente decir a la familia que serán recibidos por dos personas, cuyos nombres conocen también desde este momento. Conviene tener muy presente que los terapeutas entran a formar parte del sistema familiar mientras dura la terapia.

Síntesis del planteamiento hecho al pedir consulta. Se trata de un resumen que destaca aquellos elementos informativos que pueden ser útiles para plantear la hipótesis antes citada. Todo puede ser aprovechable, aunque entre los datos y cuestiones planteadas como "importantes" por parte de la familia, los terapeutas deberán dar preferencia a aquellos que, desde el enfoque sistémico, aparezcan como "prevalentes" para la formulación de la hipótesis y delimitación de los objetivos que circunscriban la acción terapéutica.

Parece importante ponderar aquí las actitudes de la familia tal y como se han transmitido en la información recogida, especialmente en el tema de las resistencias para participar en la terapia, grado de confianza/esperanza en lo que pueda hacerse, convencimiento respecto a la necesidad o utilidad de hacer este tipo de consulta, etc., así como el grado de ansiedad que se percibe en la petición de ayuda.

Todos estos aspectos, como demuestra la experiencia, forman un tejido que facilita el comenzar a labrar un diseño en una dirección muy concreta y delimitada.

Miembros que se citan para la P.E.F. En la primera llamada telefónica hecha por la familia se les comunica que el modo de trabajar es recibiendo a *toda la familia*, entendiendo como tal a todos los miembros que viven bajo el mismo techo y unidos por vínculos de sangre. Esta es la norma a dar y cuya aceptación o rechazo empieza a proporcionar datos acerca de la actitud familiar ante el hecho consultado.

En la segunda llamada, hecha desde nuestra consulta, puede introducirse alguna modificación sobre la pauta dada, tal como indicar que algún hijo muy pequeño no tenga que venir. En línea general tratamos de no eliminar a ninguno, ya que la presencia de niños pequeños permite descubrir algunas interacciones sistémicas entre miembros muy significativos. Es curioso ver en la sesión que cuando un bebé se agita o empieza a manifestarse inquieto por cansancio, aburrimiento o por su mismo modo de ser, hay un miembro del sistema que asume la tarea de tranquilizarlo, calmarlo, etc., descubriendo algunas veces la actitud distante y fría, carente de ternura y escasa de relaciones que engendran apego de la madre frente a la postura solícita del padre o algún hermano.

Es en este punto donde puede introducirse el criterio de que venga con la familia aquélla o aquellas personas significativas que, como se ha dicho en otro lugar, pueden tener en sus manos niveles de poder que no conviene dejar sueltos.

Solemos destacar en estos contactos telefónicos que queremos ver a toda la familia, al menos una vez, dejando así la posibilidad de dividir el sistema total en subsistemas en función de lo que la dinámica de la terapia vaya aconsejando como más útil y conveniente.

Si la familia no viene completa una vez transmitida la necesidad de que sea así, habrá que indagar qué ha motivado el resistir y descalificar nuestro modo de trabajar. En ello puede empezar a descubrirse el funcionamiento familiar frente al problema o al paciente designado, aparte de otros aspectos que van inherentes al deseo de progresar o al funcionamiento paralizante de cualquier intento de cambio.

2. El contacto directo con la familia entera

Pasado el primer trámite, tal y como queda sintetizado en las llamadas telefónicas, se celebra la primera sesión de trabajo con la familia. En ella, como se ha anticipado, empieza la Terapia Familiar, de tal modo que al hilo que se recoge información directa y se observan las interacciones, se empieza a actuar.

Un objetivo prioritario de esta primera sesión es definir la hipótesis básica que explique el funcionamiento del sistema familiar que tenemos delante. Ello supone descartar las otras alternativas formuladas en la pre-sesión, así como ir seleccionando objetivos, estrategias, "pasos a dar" en las sesiones sucesivas.

No es simple la tarea aquí esbozada, sino que constituye un amplio panorama que va desde cuanto indican como importante S. MINUCHIN, STIERLIN, M. SELVINI, hasta los detalles aparentemente más insignificantes pero que constituyen piezas claves para que puedan explicarse interacciones ocultas y no siempre fáciles de descubrir. Todo ello puede contemplarse en el punto que sigue.

3. La sesión de T.F. con su correspondiente registro de datos ⁽¹⁾

En nuestra práctica habitual contamos con un Modelo para la recogida de datos (P.E.F.) que es amplio y complejo. Quien lo maneje puede pensar que es imposible recoger toda esa información en una sola sesión, y es cierto. No se trata de completar todo en una sesión, cosa utópica en cualquier enfoque y planteamiento, sino de tener un cuadro de referencia en torno al cual organizar todo lo que interesa conocer de un sistema familiar, aunque vaya saliendo de un modo desordenado y aparentemente anárquico. Mi intención al confeccionar el P.E.F. ha sido poder ofrecer un todo unitario y coherente y cuyos puntos fundamentales, aparte de los de registro personal y de identificación, son los siguientes:

1. Nombre P.D. y edad.
2. Estudios/profesión.
3. Fecha contacto telefónico, con...
4. Fecha 1ª Entrevista Familiar, con... y ...
5. Enviado al/por...
6. Participantes de la P.E.F.
7. Distribución del espacio al inicio de la P.E.F. y comentario sobre la misma.
8. Motivo de la consulta (inicial/patente, planteado verbalmente en la PEF por..., planteado telefónicamente por...)

(1) Ver también ficha SF, pág. 568-573

9. Definición del problema objeto de consulta (por quien lo expone, por los otros, por el P.D.)
 10. Mentalidad del S.F. ante el problema consultado.
 11. Empatía/Hostilidad del S.F. ante el problema expuesto.
 12. Grado de acuerdo/desacuerdo en su formulación. (Reformulación del problema (y quién/quienes lo reformulan)
 13. Comprensión del S.F. de la situación motivacional.
 14. Motivación para trabajar juntos problemas comunes del S.F.
 15. Soluciones intentadas hasta ahora (fecha).
 16. Eficacia de las mismas (consultas anteriores, consejos/tratamientos dados, duración de los mismos, eficacia o resultados obtenidos, razón abandono).
 17. Alternativas no intentadas, aunque formuladas (cuáles, quién las propuso, quién las rechazó y por qué).
 18. Qué esperan obtener de la T.F.
 19. Definición del "cambio" que desean obtener.
 20. "Cambios que desea obtener el P.D.
 21. Cambio-1 y Cambio-2.
 22. Actitud del S.F. ante el cambio-2
 23. Registro de cambios/manejo del espacio durante la P.E.F. (sentido y reacción de cada uno).
 24. Mapa de comunicaciones transaccionales intrasistémicas.
 25. Interacciones (quién interrumpe a quién y cuando; en qué temas se interrumpe y quién; quién domina las interacciones: poder).
 26. Modelos alternativos de comunicación intrasistémica.
- Sobre el contexto familiar que puede detectar la serie de datos anteriores, hay que indagar acerca de la dinámica que se estructura en torno al síntoma o síntomas que afectan al P.D.
- Por ello nuestro modelo insiste en este punto a través de los siguientes:
27. Sintomatología prevalente en el S.F. (tanto en el S.F. como en el P.D. y en una triple dimensión: AP (antiguos y persistentes), AT (antiguos y temporales) y R (reciente aparición)
 28. Síntoma central en el S.F.
 29. Comportamiento sintomático en el S.F. (tipos): y observaciones.

30. Factores sistémicos influyentes (con influjo positivo y nexos con el síntoma; con influjo negativo y nexos).
31. Interpretación *sistémica* de la relación "síntomas-factores".
32. Posible utilización terapéutica de los síntomas y cuáles (analizar, dinamizar, controlar, eliminar y prescribir).
33. Comportamiento del P.D. (prevalente, provocativo, y otras modalidades que se especifiquen en el modelo/dossier).
34. Aspectos del S.F. (alianzas, comunicación, confines intrasistémicos, extrasistémicos, confusión de roles, dobles vínculos, triángulos perversos, mitos, poder, etc., junto a otros allí detallados).
35. Mensajes intrasistémicos en relación con el P.D. (de contenido, de relación, confirmados, no-confirmados, rechazados, ignorados).
36. Código de los mensajes: tipo y contenido.
37. Interacción familiar: aspectos y modos.
38. Actitud del S.F. ante posibles "cambios" (deseo, poder, actitud/disposición, lucha... etc).
39. Diagnóstico sistémico (del P.D., del S.F....).
40. Diagnóstico estructural del S.F.
41. Otras apreciaciones diagnósticas.
42. Planteamiento del "contrato terapéutico"
43. Objetivos primarios de la T.F. (contenidos, prescripciones, etc.)
44. Estrategias terapéuticas a tener en cuenta.
45. Alternativas terapéuticas futuras.

Aparte del *Modelo P.E.F.* (Stirpe, 1980) y confeccionado sobre la experiencia acumulada, contamos con un breve modelo que facilita la toma de datos sobre cada sesión posterior en particular. El P.E.F. va completándose poco a poco, canalizando así todo el trabajo terapéutico; el *Modelo S.T.F.* (Sesión de Terapia Familiar) consta de 20 ítems que recogen lo que sucede en una sesión concreta (participantes, cambios en el espacio, nuevas interacciones, contenidos trabajados en la sesión utilización terapéutica de los síntomas, tareas, prescripciones, etc...), instrumento que posibilita un resumen de cada sesión y que ayuda a montar las estrategias de las siguientes.

Es por ello, un apoyo más en la tarea de mantener en progreso el cometido de enriquecer la información para, sobre ella, seguir interviniendo con las técnicas adecuadas.

3. Cómo diagnosticar

De cuanto viene exponiéndose pueden concluirse algunas ideas en relación con el modo de diagnosticar, dado que en las interacciones que empiezan a aparecer en la P.E.F. pueden apoyarse modos de seguir conociendo el funcionamiento del S.F.

No obstante, algunas ideas pueden concretarse en resortes que, utilizados por el terapeuta, contribuyen a clarificar la dinámica interna de la familia. Voy a exponer cuatro técnicas que facilitan esta labor:

- a) Construir el "mapa emocional" de la familia.
- b) Conocer el plano de la vivienda/casa.
- c) Saber cómo están en la sala de estar en casa.
- d) Observar la colocación en el espacio cuando acuden a la sesión del T.F.

a) Construir el mapa emocional de la familia

Ha de hacerse a partir de los datos recogidos en la P.E.F. y con la incorporación de aquellos que, obtenidos en las llamadas telefónicas, permitan configurar con mayor exactitud lo que es la vida emocional de la familia.

Debe hacerse gráficamente y mediante la colocación en el centro de un folio/cartulina al P.D. procediendo a colocar con respecto a él a los demás miembros del S.F.

La representación gráfica de las interacciones intrasistémicas se reflejará mediante el trazado de líneas que indiquen las atracciones/vinculaciones positivas o las repulsiones/rechazos existentes entre cada miembro y el resto de los que integran el S.F. Estas relaciones deben quedar representadas con claridad y en doble sentido, ya que no es lo mismo que el padre tenga una vinculación positiva con una hija (lo que podría explicarse mediante una línea de trazo continuo y fuerte) que, simultáneamente, la hija no corresponde a tal actitud paterna (lo que se representaría con una línea de puntos o trazos y con la intensidad leve que representa). En caso de no existir ningún tipo de relación, no se marca ningún tipo de trazado. Según los tipos de interacciones (positivas, negativas, intensas, superficiales, constantes, ambivalentes, intermitentes) pueden emplearse distintos colores o diferentes modelos de trazados entre los miembros.

Fácilmente se advierte que con un gráfico de esta naturaleza quedan claramente indicadas las vinculaciones, alianzas, coaliciones, triangulaciones, así como la existencia de miembros aislados o periféricos, todo ello según los conceptos ya expuestos de cada una de estas modalidades de interacción y comunicación. Aquí han de entrar aquellas figuras vinculadas al contexto familiar, aun cuando no vivan bajo el mismo techo, dato que enriquece poderosamente el conocimiento intuitivo de un sistema familiar.

b) Conocer el plano de la vivienda/casa

Consiste en que un miembro, preferentemente el P.D., o con la colaboración de todos, confeccione sobre una cartulina el "plano" de la vivienda que habitan. Es una repetición del modo habitual de mostrar un plano cuando se intenta vender un piso a alguien. Una vez trazado el "plano" hay que especificar quién ocupa cada habitación para, de este modo, ver cómo están distribuidos los miembros en el territorio físico que ocupan.

La finalidad es poder descubrir de manera rápida e intuitiva dos temas importantes que condicionan el tipo y modelos de interacción familiar:

- El tema de los *confines físicos o territoriales*: el espacio en que la persona se encuentra consigo misma como requisito para la adquisición de la intimidad, estructuración de la identidad y derecho a la independencia y la autonomía.
- El tema de los *confines emocionales* según los cuales cada uno define diferenciación y marca los límites que regulan las relaciones con los otros. Hay que decir con frecuencia que estos confines emocionales están confusos porque también lo están los físicos o territoriales.

Este resorte exploratorio es particularmente útil con niños y adolescentes, y de su adecuada utilización se siguen muchas aplicaciones inmediatas respecto a "cambios deseados", "delimitación del propio terreno", "separación entre subsistemas" y "separación entre generaciones".

A veces da pie para entrar en un tema cuya ampliación nunca puede preverse: Que te gustaría a ti -dicho a un P.D.- que cambiase en esta distribución?... Soy testigo de muchos cambios en la distribución de las dependencias de la casa para conseguir que un hijo o una hija encuentre una acomodación más acorde con exigencias profundas de su desarrollo evolutivo. Por ello puede utilizarse como puerta de entrada para otros temas más profundos.

c) *Saber cómo están en la sala de estar de casa*

La familia actual gira en torno a un gran espacio- el salón de estar en la mayoría de las viviendas- que aglutina y unifica a la familia en muchos momentos de la jornada. Si es verdad que contemplamos profundas transformaciones en cuanto a momentos tradicionalmente aptos para "estar juntos", tales como los clásicos horarios de comer y cenar, todavía la familia coincide en algunas horas. Aunque sea simplemente para "estar", para ver la televisión, para no comunicarse a nivel verbal.

Se trata de dibujar "a vista de pájaro", la sala donde, por ejemplo, ven la televisión, ya que es un hecho frecuente. Se invita al niño a que dibuje el televisor- denominado ya en la cultura francesa como "el tercer padre" (1)- y dibujar a los miembros según se coloquen en la sala. En la mayoría de los casos se ocupan puestos fijos que, indirectamente, tienen bastante que ver con los aspectos vinculados a la proximidad entre determinados miembros, el aislamiento de alguno, la cercanía emocional de otros. Puede partirse de qué lugar ocupa cada cual cuando se sientan a comer, o dónde colocan a un invitado que viene a compartir la mesa o a pasar un rato.

Cuanto se detecte mediante esta técnica hay que relacionarlo con lo descubierto por los procedimientos anteriores para, de este modo, reforzar las coincidencias que no suceden por acaso, sino que están basadas en mecanismos de interacción vividos inconscientemente pero fuertemente.

También en este sentido la realidad ofrece alternativas de intervención en forma de introducir cambios que vayan más allá del simple manejo del espacio: tras cambios en la colocación pueden facilitarse nuevas interacciones entre los miembros que empiezan a estar físicamente más cercanos.

d) *Observar la colocación en el espacio cuando acuden a la sesión de T.F.*

Esta colocación, aparentemente casual, obedece también a pautas aprendidas y a distancias mantenidas. Sirve para construir el "mapa emocional" y saber "quién es quién", como se ha visto ya en varias ocasiones. Es ahí donde se apoya mi convencimiento personal de que manejando este espacio de la sala de terapia pueden conseguirse muchas cosas en relación con la estructuración de la dinámica familiar: unir a los miembros del subsistema conyugal sentándolos juntos, delimitar el mundo de los hijos colocándolos en una zona del círculo que se forma en el lugar que los atendemos, moviendo a quien convenga para que hablen entre sí, se miren, se acerquen. Yo mismo me muevo cediendo mi

lugar a otro que me interesa que esté donde yo estaba, para ir colocándolos como me convenga y así, mediante el uso del espacio, llegar a trasmitirles una idea que captarán perfectamente cuando la vean plasmada en la realidad de la nueva colocación.

Aparte de lo indicado, la colocación de la familia en el espacio disponible nos permite ver cuáles son sus concepciones de fondo respecto a la interacción emocional ya que en toda posición/colocación física se expresan actitudes internas tales como:

- La propia identidad personal es una diferenciación progresiva y delimitante entre el espacio interior y exterior.
- Si no hay espacio exterior se dificulta la conquista del espacio interior o vital.
- Hay un territorio físico y un territorio emocional.
- El espacio que me dejan los otros supone poder tener un lugar para mí y para, desde él, relacionarme con los otros de modo sano.
- El espacio responde a la necesidad profunda de sentirse "individuo", "persona".

E.T. HALL, citado por J.Y. DESJARDINS en una lección sobre el acercamiento erótico corporeo que sintetiza A. TONINI (1982), clasifica las distancias en función de términos dinámicos de cercanía o distancia emocional en distancia íntima, social, personal y pública. La *distancia íntima* presupone un contacto; tales por ejemplo, la que una madre tiene con el hijo cuando lo coge en brazos o la de dos personas en una relación amorosa. El contacto físico tiene notables valores pragmáticos en este tipo de distancia puesto que refuerza la intimidad de la relación espacial. La *distancia social* se caracteriza porque en ella el único contacto directo es visual; el espacio actúa como defensa potencial respecto a posibles "intrusiones" del exterior. Este tipo de distancia se da, por ejemplo, al discutir un negocio, al dirigirse a un superior, al hablar con una persona a la que no se ha tratado nunca. El espacio, en tal caso, más que unir, separa y se ocupa de objetos: una mesa, un mueble, un escritorio, confirmando así que la distancia que se tiene es la más apropiada para este tipo de relación. Muchas relaciones profesionales se enmarcan dentro de este tipo de distancia y así, por citar algún caso, el médico se "distancia" gracias a la bata o al talón de recetas, el psicoanalista gracias al diván, el profesor merced a la mesa, todo lo cual estructura lo que puede denominarse *distancia de guardia* en la que juega un gran papel cualquier objeto distanciador y no discutido.

La *distancia personal* es una distancia más o menos a vecinada donde ocasionalmente es posible tocar a una persona si se alarga el brazo, pero en la que no se eliminan los límites claros de un espacio personal propio. Con otras palabras: hay que hacer algo para llegar al otro porque la distancia es algo alejada, aunque sea alcanzable. Esta distancia es la que funciona habitualmente entre amigos o compañeros de trabajo interesados en algo común. Supone, por ello mismo, un nivel de confianza que facilita que el espacio-separación pueda ser vencido cuando alguno de ellos lo estime oportuno. Esta distancia está vedada en muchas situaciones profesionales mientras que en la Terapia Familiar parece la más idónea desde el momento en que el terapeuta empieza a formar parte del sistema familiar y es aceptado a participar en algunos niveles de la interacción interna del sistema. En las terapias clásicas abundan, por el contrario, distancias sociales y distancias de guardia, más o menos racionalizadas con la famosa teoría de la abstinencia del terapeuta. En la T.F., usada convenientemente, abre muchas posibilidades de intervención. Finalmente puede hablarse de la *distancia pública* que es la usada en las relaciones formales; es una especie de distancia de seguridad donde el carácter de relación interpersonal directa queda totalmente desdibujado. Se da, por ejemplo, en una conferencia pública, en una lección académica, en una misión diplomática.

Todo ello contribuye a clarificar cómo funcionan muchas familias y cómo puede funcionar con ellas en el ambiente de la terapia. La interacción puede apoyarse aquí en el establecimiento de relaciones entre "distancia física" y "contacto físico" que puede ponerse en juego en el mismo interior de la sesión. El tocar y tocarse representa una comunicación que muchas familias han desterrado en sus hábitos de relación. Con ello se privan de un lenguaje que expresa infinidad de sentimientos, estados de ánimo, deseos con los que se habla -sin hablar- de amor, acuerdo, amistad, dependencia, hostilidad, rechazo, indiferencia... Por ello el contacto físico y el desplazamiento corporal del mismo terapeuta, expresa atención, interés por aquello que se dice, deseo de ayudar, interés por saber más del que habla, es inevitable que desde estos gestos se transmita a la familia cómo puede ser la mejor relación aún sin utilizar palabras.

Caben aquí algunas modalidades más expresivas y significativas:

- A. Si hablo estando de pie junto a una persona que está sentada, expreso una relación de fuerza a mi favor.
- B. Si me coloco más bajo que otra persona, sentándome en el suelo, por ejemplo, le concedo ventaja y poder sobre mí.
- C. Si me siento a su lado expreso complicidad.

- D. Si me acerco mucho, expreso más claramente mi emotividad y/o afectividad hacia la otra persona.

Estas mismas aproximaciones de HALL, permiten plantear algunas intervenciones en las que la articulación de lo que constituye el manejo del espacio, lo que aporta el desplazamiento del terapeuta como expresión de apoyo, alianza, ayuda, interés, etc. y la libertad para acompañar con un gesto de acercamiento cualquier intervención verbalizada, se convierten en estrategias que desencadenan nuevas interacciones y permiten aprender nuevos modos de relación y comunicación.

Paralelamente a la colocación en la sala de terapia conviene observar, como muy bien indica CIGOLI (1977a), *quién habla, a quién habla y cómo habla*, ya que en este entramado se construye una verdadera modalidad dentro del sistema. Si, como ya se ha dicho, el terapeuta abre brecha en la sesión mediante una pregunta del tipo de "¿Quién quiere hablar de lo que les trae aquí?", el modo como se desarrolle la intercomunicación a partir de este momento, dará indicaciones preciosas para conocer matices como la estructura de poder, las coaliciones, los tipos y niveles de comunicación, los niveles de conflictividad, las áreas de acuerdos, etc.

Sobre este terreno podrían esbozarse las posibles reestructuraciones, la provocación de crisis, los desafíos y las prescripciones.

4. Con qué diagnosticar

Los instrumentos diagnósticos en la dinámica familiar pueden seleccionarse entre las numerosas técnicas que existen en este campo. Sin embargo, los terapeutas de la familia tendemos a prescindir de pruebas estandarizadas como las utilizadas para el psicodiagnóstico. La razón es que lo que interesa conocer de la familia, desde un enfoque sistémico, no puede ser medido con los tests más difundidos.

Esto no invalida que, en realidad, el diagnóstico de la familia pueda servirse de algunas técnicas a las que quiero aludir para que quien desee conocerlas y manejarlas pueda tener un punto de referencia.

CIGOLI (1977a) ha reagrupado algunas técnicas cuyo conocimiento puede ofrecer al terapeuta puntos de apoyo para cuando necesite objetivar algunos datos deducidos de su contacto con la familia. Sobre la selección de dicho autor,

y citando entre paréntesis las páginas de la obra citada, es oportuno señalar las técnicas siguientes:

- Tests de color (130)
- Dibujo hecho por la familia (131)
- Entrevista de diagnóstico de la familia (131)
- Cuestionario QW/F (135)
- Consenso
- Escultura de la familia (140)
- Test de interacción familiar (144)
- Técnica del cambio de roles (155)
- Técnica de SINFAN (157)
- Test del juego interactivo (144)
- Forschah consensual (155)
- Cuestionario de conflictividad conyugal (145)
- Técnica de las divergencias reveladas (154)
- Análisis del proceso interactivo (145)
- Juego estructurado (159)
- Elección del objeto apropiado (148)
- Reconocimiento de estructuras (150)
- Proyectar juntos (151)
- Discusión de un proverbio (152)
- Marionetas como técnica expresiva de interacción familiar (153)

Cada una de estas técnicas tiene su metodología y sus aplicaciones. Es evidente que constituyen un arsenal de resortes que cada terapeuta utilizará tanto en función de sus necesidades como según las características de la familia a estudiar en cada caso.

MINUCHIN (1978) presenta una selección de "tareas familiares" que puedan utilizarse durante el desarrollo de una sesión de T.F. con vistas a descubrir los modelos interactivos y comunicativos que se ponen en juego: preparar entre todos un menú para cenar de acuerdo con unas pautas dadas, hablar de un litigio familiar reciente, que cada uno hable de lo que le guste hacer en familia, construir entre todos una historia a partir de una lámina, etc.

Personalmente, aunque utilizo esporádicamente alguno de los resortes indicados, me centro en lo indicado en páginas anteriores (mapa de la familia, plano de la vivienda, salón de estar en casa y colocación en la sala de T.F.), ayudado por las cuestiones que hemos recogido en el *Cuestionario S.F. 1982* de "Stipe" y en el que a través de 100 ítems complementados con 12 ítems añadidos para analizar algunos aspectos de la pareja, se analizan todas y cada una de las cuestiones que estimamos importantes para formar una idea con respecto al funcionamiento de las familias en observación.

Dado que su presentación haría muy extenso este apartado, me remito a dicho Cuestionario para un mejor conocimiento de cuanto evalúa y desea medir.

5. Para qué diagnosticar

Los objetivos finales de un diagnóstico de la dinámica familiar pueden quedar sintetizados en los puntos siguientes:

1. Delimitar muy bien los términos del problema para definir con exactitud el ámbito de la terapia a seguir. Tal delimitación ayudará a formular con precisión el contrato terapéutico con la familia.
2. Describir las características de ese sistema familiar en el momento concreto en que lo vemos y observamos. Con otras palabras: ver qué tiene que ver el problema consultado con el tipo de familia que tenemos delante.
3. Descubrir las reglas de funcionamiento del sistema familiar, mediante el análisis de los valores, ritos, mitos, interacciones, etc. y los aspectos relacionados con la circularidad con que funciona tal familia.
4. Delimitar los aspectos a reestructurar mediante la terapia posterior: clara definición de los objetivos de Cambio-2 en esa familia.
5. Formarse una idea lo más aproximada posible respecto a las soluciones intentadas hasta ahora, así como de sus efectos y de los posibles resultados obtenidos.
6. "Este tipo de diagnóstico es inseparable del pronóstico. La puesta en práctica de las transacciones de la familia, después que ésta se haya asociado al terapeuta, revela modelos transaccionales alternativos que se pueden estimar significativos en el interior del crecimiento terapéutico" (MINUCHIN, 1974, 133).

Sobre estos criterios, todos los datos recogidos mediante los pasos anteriormente descritos, ha de trazarse un camino a seguir en las sesiones de T.F.

No hay diagnóstico de la dinámica familiar si no es en función de la terapia y hay que destacar la idea de que, por mucha y buena que sea la información previamente recogida, no bastará si no hay un trabajo posterior mediante las técnicas terapéuticas que se describen en el capítulo siguiente.

APENDICE 1.

Instrumentos para la evaluación previa a la Terapia Familiar y la Terapia de Pareja

1.1. MODELOS DE FICHA DE DATOS PARA LA CONSULTA

1.1.1. FICHA DE FAMILIA (T.F.)

Apellidos Nombre Ref.
 Fecha nacimiento Edad actual
 Lugar nacimiento
 Domicilio y Ciudad (C.P.)
 Teléfonos de contacto
 Fecha de hoy

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA

NOMBRE	EDAD	PROF/ESTUD.	OBSERVACIONES
Padre			
Madre			
Hijo 1º			
Hijo 2º			
Hijo 3º			
Hijo 4º			
Hijo 5º			
Hijo 6º			

Si vive algún otro familiar en casa, indique quién:

Vienen a consulta por consejo de
 Indique el motivo o motivos de la consulta

¿Aceptan la intervención del equipo de STRPE en la consulta que hacen? (sí o no)
 ¿Aceptan su presencia tras el espejo unidireccional?
 ¿Aceptan la grabación en Vídeo conforme a las condiciones que se especifican en la Autorización que devuelven firmada?
 ¿Aceptan abonar al final de cada sesión los honorarios que se le han indicado?
 ¿Conocen y aceptan todos los miembros de la familia las condiciones y normas de nuestro modo de trabajar?
 ¿Desean añadir algo?

(Entreguen esta hoja al ser recibidos en Consulta. Gracias)

Fecha y firma:

Sobre estos criterios, todos los datos recogidos mediante los pasos anteriormente descritos, ha de trazarse un camino a seguir en las sesiones de T.F. No hay diagnóstico de la dinámica familiar si no es en función de la terapia, y hay que destacar la idea de que, por mucha y buena que sea la información previamente recogida, no bastará si no hay un trabajo posterior mediante las técnicas terapéuticas que se describen en el capítulo siguiente.

APENDICE 1.

Instrumentos para la evaluación previa a la Terapia Familiar y la Terapia de Pareja

1.1. MODELOS DE FICHA DE DATOS PARA LA CONSULTA

1.1.1. FICHA DE FAMILIA (T.F.)

Rel.

Apellidos Nombre
 Fecha nacimiento Edad actual
 Lugar nacimiento
 Domicilio y Ciudad (C.P.)
 Teléfonos de contacto
 Fecha de hoy

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA

NOMBRE	EDAD	PROF/ESTUD.	OBSERVACIONES
Padre			
Madre			
Hijo 1º			
Hijo 2º			
Hijo 3º			
Hijo 4º			
Hijo 5º			
Hijo 6º			

Si vive algún otro familiar en casa, indique quién:

Vienen a consulta por consejo de
 Indique el motivo o motivos de la consulta

¿Aceptan la intervención del equipo de STIRPE en la consulta que hacen? (sí o no)
 ¿Aceptan su presencia tras el espejo unidireccional?
 ¿Aceptan la grabación en VÍdeo conforme a las condiciones que se especifican en la Autorización que devuelven firmada?
 ¿Aceptan abonar al final de cada sesión los honorarios que se le han indicado?
 ¿Conocen y aceptan todos los miembros de la familia las condiciones y normas de nuestro modo de trabajar?
 ¿Desean añadir algo?

Fecha y firma:

(Entreguen esta hoja al ser recibidos en Consulta. Gracias)

FAMILIA
MATRIMONIO

1. GENOGRAMA SFO PADRE/MARIDO	2. GENOGRAMA SFO MADRE/ESPOSA	3. GENOGRAMA S.F.CREADO

OTROS DATOS DE INTERES DE LOS GENOGRAMAS:

CODIGO PARA COMPLETAR LA FICHA F.T.G.

- Datos de identificación de la familia o pareja:
- Familia o pareja:
- Ref:
- P.D. y edad
- Enviados por:
- Domicilio postal y teléfono:

PRIMERA LLAMADA:

Se consigna la fecha, quién la hace desde el sistema familiar y quién la recibe en el sistema terapéutico.

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

La persona que recibe la llamada telefónica hace una breve síntesis del motivo que presenta la familia o la pareja. Interesa consignar esta información con la mayor precisión posible, destacando el orden con que presentan sus preocupaciones. No es casual que en la primera demanda aparezcan como problemas aspectos que posteriormente, a veces los motivos: 1, 2, 3, etc. La comparación con lo que dirán en la segunda llamada y lo que saldrá en la 1ª sesión, es muy ilustrativa en orden a ver la dinámica de la problemática que les afecta.

2. ESTRUCTURA DE LA FAMILIA

NOMBRE	EDAD	PROF/ESTUD.	OBSERVACIONES
Padre			
Madre			
Hijo 1º			
Hijo 2º			
Hijo 3º			
Hijo 4º			
Hijo 5º			

Fecha de la 1ª llamada Recibida por
 Completará datos en 2ª llamada en días de a
 Citados para 1ª Sesión el día a las
 Deberán venir a la 1ª sesión:
 Serán recibidos por y
 Honorarios indicados:
 Cuestionario previos entregados:
 Fecha de entrega: Deberán enviarlos antes del día
 Devueltos el día
 Anulan la consulta solicitada el día
 No se ha vuelto a tener noticias:
 Remitidos a la consulta de: el día
 Causa:
 Otras observaciones a tener en cuenta: ¿Acudieron a dicha consulta?

1.3. LA SEGUNDA LLAMADA TELEFONICA

Familia/Pareja Ref.
 Fecha 2ª llamada Hora Duración
 Terapeuta que la hace La recibe

Recogida de datos:

M- Motivo de la consulta: (.....)
 T- Tiempo/Duración del problema consultado (.....)
 P- Presentación del problema que les preocupa (.....)
 S- Solución que hacen a "Stirpe" (.....)
 A- Actitud de quien pide la consulta (.....)
 C- Contra-actitud del terapeuta (.....)
 D- Datos que se le han dado respecto a la metodología de "Stirpe" (.....)
 R- Respuesta a nuestra metodología (.....)
 H- Puntos para la formulación de Hipótesis:
 H-1: Problemática central:
 H-2: Problemática periférica:
 H-3: Favorable a la "circularidad":
 H-4: Dificultades a la "circularidad":
 H-5: Amenazas a la "neutralidad":
 Citados para el día: a las horas.
 Miembros citados definitivamente:
 Otras observaciones de quien hace la 2ª llamada:

1.4. CODIGO PARA COMPLETAR LA 2ª LLAMADA TELEFONICA

M - MOTIVO DE LA CONSULTA:

M.1. Determinación del nivel mental de un miembro del S.F.

- M.1.1. Por razones objetivas que preocupan
- M.1.2. Para aclarar dudas que preocupan
- M.1.3. Por otras razones: indicar cuáles.

M.2. Problemas escolares de un miembro del S.F.

- M.2.1. Dificultades en los estudios
- M.2.2. Escaso rendimiento escolar
- M.2.3. Fracaso escolar así definido
- M.2.4. Otros trastornos de la vida escolar: cuáles.

M.3. Orientación de un miembro del S.F.

- M.3.1. Orientación personal
- M.3.2. Orientación académico-escolar
- M.3.3. Orientación vocacional
- M.3.4. Orientación profesional
- M.3.5.
- M.3.6.

M.4. Crisis personales de un miembro del S.F.

- M.4.1. Desequilibrio de personalidad
- M.4.2. Trastorno de conducta: indicar cuál
- M.4.3. Conflictos de adaptación: indicar área
- M.4.4. Problemas sexuales: especificar cuál

M.5. Cuadros clínicos previamente diagnosticados

- M.5.1. Trastorno grave de personalidad: indicar cuál
- M.5.2. Trastorno leve de personalidad: indicar cuál
- M.5.3. Estado o crisis depresiva
- M.5.4. Alcoholismo
- M.5.5. Drogadicción

M.6. Conflictos en las relaciones familiares

- M.6.1. Conflictos prematrimoniales
- M.6.2. Conflictos matrimoniales
- M.6.3. Conflictos relación padres-hijos
- M.6.4. Conflictos relación entre hermanos
- M.6.5. Conflictos con S.F.O. del padre
- M.6.6. Conflictos con S.F.O. madre
- M.6.7. Otros conflictos: indicar cuáles

M.7. * Explorar lo que supone el motivo de la consulta en orden a la estabilidad, cohesión y capacidad de progreso de la familia como sistema total

T - TIEMPO/DURACION DEL PROBLEMA QUE CONSULTAN

- T.1. Años
- T.2. Meses
- T.3. Días
- T.4. Hoy
- T.5. Ahora mismo: crisis aguda
- T.6. No sabe precisar
- T.7. * Explorar si en este tiempo han intentado otras soluciones y cuáles, así como la eficacia/ineficacia que han tenido. Igualmente si está bajo tratamiento de algún tipo (médico, psiquiátrico, terapéutico, psicológico...)

P - PRESENTACION DEL PROBLEMA QUE LES PREOCUPA.

(Forma de exponer la problemática que consultan)

- P.1. Directa y claramente
- P.2. Dando rodeos y con explicaciones colaterales que hacen confusa la situación que desean consultar
- P.3. Distanciándose personalmente del eje del problema
- P.4. Hablando de sí mismo como implicado en el problema
- P.5. Forzado por quien le ha aconsejado acudir a terapia y con escasa motivación para lo que van a hacer
- P.6. Otras modalidades en la presentación: describirlas
- P.7. * Explorar si el paciente y los demás miembros comparten este modo de presentar la situación.

S - SOLICITUD QUE HACEN A "Stirpe"

(Lo que desea quien hace la llamada)

- S. 1. Una consulta confusa sin especificar bien los límites ("hablar con un psicólogo", "consultar un problema")
- S. 2. Una terapia sin especificar más
- S. 3. Aplicación de tests
- S. 4. Solución inmediata de una situación crítica
- S. 5. Terapia de grupo: explorar por qué
- S. 6. Terapia de pareja: explorar por qué
- S. 7. Terapia familiar: explorar la idea que tienen de esta modalidad
- S. 8. Saber si un problema tiene solución o arreglo, pero sin ánimo de iniciar un tratamiento terapéutico
- S. 9. Que atendamos **solamente** al paciente que presentan, sin querer implicarse los demás miembros de la familia o la pareja

A - ACTITUD DE QUIEN PIDE LA CONSULTA Y NOS HABLA

(Forma en la persona se aproxima a nosotros)

- A. 1. Angustia (forma de hablar, tono de voz, atropello en la exposición, sin dar forma clara a lo que expone, por la urgencia con que solicita ser atendido, etc.)
- A. 2. Desorientada: no sabe bien lo que quiere, le han remitido a nosotros y no sabe bien por qué ni para qué, pero sin angustia.
- A. 3. Confiada: confía en nosotros, le han apoyado para que acuda a consulta, viene con esperanzas. (Si la esperanza es excesiva: "me han dicho que si vamos ahí todo se arreglará", tomar nota de ello)
- A. 4. Desconfiada: no espera nada, viene porque se lo han aconsejado, porque lo quieren otros de la familia o pareja, dudas sobre la eficacia de este paso, "por si suena la flauta..."
- A. 5. Urgente: exige ser atendidos inmediatamente, en el mismo día, enseguida.
- A. 6. Agresiva: al imponer días y horas para ser recibidos, poniendo condiciones a nuestra metodología, queriendo dominar la situación y rechazando algún aspecto de nuestro modo de trabajar.
- A. 7. Irónicamente: "Sé que esto no sirve para nada, pero...", o frases semejantes.
- A. 8. Histérica: manipulando la información que da, ocultando datos, contradiciéndose.
- A. 9. Reluctante: no responde directamente a lo que se pregunta, no da toda la información que tiene, "ahora no puedo decir todo...", no puedo hablar claro, hay gente, me están escuchando..., no sé si decir todo..."
- A. 10. Otras actitudes: describirlas.

C - CONTRA-ACTITUD DE TERAPEUTA

A partir de la actitud de la persona con quien hablamos es importante descubrir la "contra-actitud" del terapeuta, ya que sobre ella se construirán elementos favorables o negativos a la relación terapéutica y la neutralidad durante la misma. Entrar aquí sentimientos, afectos, emociones de varios tipos que es preciso tener bien delimitadas.

D - EXPLICACION DE NUESTRA METODOLOGIA

* Este es el momento de exponer nuestra metodología con más detalles que en la 1ª llamada, destacando especialmente los puntos siguientes:

1. Que deben venir todos los miembros de la familia
2. Que serán recibidos por el Director del Centro y otro terapeuta.
3. Que el equipo seguirá la sesión detrás del espejo
4. Que grabaremos la sesión en vídeo y que deberán entregar firmada la autorización para tal grabación.
5. Que todos los miembros de la familia han de conocer estas condiciones de trabajo y cuantas se especifican en el Contrato que se les ha entregado.

R - RESPUESTA A NUESTRA METODOLOGIA

- R. 1. Aceptación sin dificultades
- R. 2. Sorpresa agradable
- R. 3. Curiosidad
- R. 4. Indiferencia
- R. 5. Ponen algunos reparos: indicarlos
- R. 6. No aceptación. Rechazo
- R. 7. Duda. Consultará con los otros miembros
- R. 8. Otras: cuáles.

H - PUNTOS PARA LA FORMULACION DE HIPOTESIS SISTEMICAS

- H. 1. Problemática que se valora como "central" para la formulación de hipótesis ante la 1ª sesión de T.F. o T.P.
- H. 2. Problemática "periférica" que debe tenerse en cuenta en la formulación de las hipótesis.
- H. 3. Hipótesis de cara a la "circularidad" con esta familia o pareja: facilidades y dificultades.
- H. 4. Hipótesis de cara a la "neutralidad" con esta familia o pareja: amenazas más sobresalientes.

(Autor: José Antonio Ríos González)

1.5.1. FF (FICHA DE FAMILIA)

(Completar con bolígrafo de punta fina y letra clara/legible)

P.D.		PADRE:		MADRE:	
Edad	E.C.HH.	Lug.	Nat.	Ocup	Est.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
12					
13					

I. FAMILIA		P.D.	In:	Fin:	Ref
Padre:					
Madre:					

14. Enviado por _____

15. Motiv./síntoma: _____

16. Antig. síntoma: _____

17. Consultas previas: _____

17.1. Resultados: _____

19. Pide consulta: Fecha: _____

20. Actitud SF: _____

21. Motivación TF: _____

22. Tipo apertura SF: _____

23. ESTRUCTURA DINAMICA FAMILIAR (Al acudir a consulta: _____ de _____ de 19____)

23.1. Crisis/cisma SF	23.2. Clima fami-FES	23.3. Comunicación:T.	Nivel:	23.4. Emoción Expre.:	23.5. Estilo afectivo	23.6. " apoyo	23.7. " autoridad	23.8. " disciplina:	23.9. " educativo :	23.10. " individuac:	23.11. " interactiv:	23.12. " parental :	23.13. " sol.probl.:	23.14. " cont.desar:	23.15. Fidelidades SF:
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	---------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------------

23.16Fig.parenta: _____

23.17 FO:Relac.: _____

23.18 Lím. Emoc.: _____

23.19 Lím. físic.: _____

23.20 Miemb.sint.: _____

23.21 Antec. " " : _____

23.22 Mito domin.: _____

23.23 Poder fam.: _____

23.24 Red Social: _____

23.25 Reglas Fam.: _____

23.26 Rol Famil.: _____

23.27 Tiempo Lib: _____

23.28 Valor dom: _____

41- CO:	45- EX:	56- CT:	43- AU:	44- AC:	49- IC:	51- SR:	51- MR:	42- OR:	52- CN:
FES Fam.	P	M	1	2	3	4	5	6	(1)

Mod. Rich.Fam. JARFos/1991

(Continúa en el dorso)

PROCESO TERAPEUTICO:	FECHAS	HECHA POR	RECIBIDA POR	OBSERVACIONES Y ORDEN MOTIVO T.F.
1ª Llamada:				
2ª Llamada:				

Inicio de TF: _____ Final de TF: _____ Terapeutas: _____

SESIONES DE TERAPIA FAMILIAR:

Núm.	Fecha	Vídeo	Asisten	Terapeutas	Contenidos fundamentales de la sesión	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

CONTROLES Y SEGUIMIENTOS:

	Cues. STF-Sist					Cuest. A-TF (Ant.)						Cuest. D-TF (Durant)										Cuest. F-TF (Final)													
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P.																																			
M.																																			
H1																																			
H2																																			
H3																																			
H4																																			
H5																																			
H6																																			

(Completar con bolígrafo de punta fina y letra clara/legible)

1.5.2. FP (FICHA DE PAREJA)

23. ESTRUCTURA DINAMICA CONYUGAL (Al acudir a consulta: _____ de _____ de 19____)

22. Tipo apertura sistema conyugal: ☐ Observaciones: _____

19. Pide consulta: ☐ Fecha: ☐

18. Ciclo vital pareja: ☐

16.1. Antig. " ☐

15.1. Síntomas previos ☐

14. Enviados por ☐

11. Casados hace ☐ 13. Separados hace ☐

12. Hijos nacidos: ☐

17. Consultas previas ☐

17.1. Resultados obten.: ☐

20. Actitud del conyuge: ☐

21. Motivac. cons ☐

23.29 Valor domin ☐

23.28 Tiempo libe ☐

2. Agente ☐

23.27 Stress cony ☐

4. Distinción ☐

3. Estabilidad ☐

2. Satisfac. ☐

1. Inicio ☐

23.26 Sexualidad: ☐

2. Distribuc. ☐

1. Claridad ☐

23.25 Roles cony ☐

23.24 Reglas par ☐

23.30 Tipo Pare ☐

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(1) RES SFG/23.2.

CO. CT. AU. IC. MR. CN. OR. SR.

Med. Ficha Pareja, JARIS/1991

(Prohibida la reproducción sin citar autor)

MATRIMONIO

Ref. _____

Inicio: _____

Fin: _____

Tefos. _____

1 2 3 4 5 6

Edad: _____

Sexo: _____

15. Motivo/síntoma ☐

16. Antiguo/ " ☐

17. Consultas previas ☐

17.1. Resultados obten.: ☐

20. Actitud del conyuge: ☐

21. Motivac. cons ☐

23.29 Valor domin ☐

23.28 Tiempo libe ☐

2. Agente ☐

23.27 Stress cony ☐

4. Distinción ☐

3. Estabilidad ☐

2. Satisfac. ☐

1. Inicio ☐

23.26 Sexualidad: ☐

2. Distribuc. ☐

1. Claridad ☐

23.25 Roles cony ☐

23.24 Reglas par ☐

23.30 Tipo Pare ☐

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(1) RES SFG/23.2.

CO. CT. AU. IC. MR. CN. OR. SR.

Med. Ficha Pareja, JARIS/1991

FP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombres Edad R.C. Hnos. Lug. Nat. Ocup. Estud. St-SE

MARIDO

MUJER

| PROCESO TERAPEUTICO | FECHAS | HECHA POR | RECIBIDA POR | OBSERVACIONES Y ORDEN MOTIVO T.PAREJA. |
|---------------------|--------|-----------|--------------|--|
| 1ª Llamada: | | | | |
| 2ª Llamada: | | | | |

Inicio TP: _____ Final TP: _____ Terapeutas: _____

SESIONES DE TPAREJA:

| Núm. | Fecha | Vídeo | Asisten | Terapeutas | Contenidos fundamentales de la sesión | Observaciones |
|------|-------|-------|---------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

CONTROLES Y SEGUIMIENTOS:

| | Cuest. STP | | | | | Cuest. A-TP (ant) | | | | | | Cuest. D-TP (Durant) | | | | | | | | | | Cuest. F-TP (Final) | | | | | | | | |
|------|------------|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Espº | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espº | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OTROS CONTROLES:

| FECHAS | RESPONDEN | EVOLUCION OBSERVADA | SITUACION ACTUAL | OBSERVACIONES |
|--------|-----------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1.6. CODIGO PARA COMPLETAR LAS FICHAS FF y FP

(Autor: José Antonio Ríos González)

0. **REFERENCIA:** Número de orden en fichero y /año (ej: 2341/79)
1. **CASO:** Nombre del PD o de componentes de pareja: varón/mujer
- 2a. **EDAD MARIDO** en años cumplidos al consultar
- 2b. **EDAD MUJER:** idem
3. **ESTADO CIVIL:** 1. (S)oltero. 2. (C)asado canónicamente. 3. (cv) casado civilmente. 4. (V)iuco. 5. (Se)parado. 6. (Pd) En proceso de divorcio. 7. (D)ivorciado. 8. (Un)ión consensual-estable. 8. (Ot)ros.
- 4a. **NUMERO DE HERMANOS DEL P.D. O DEL MARIDO:** indicar número
- 4b y 4c en FF: **NUMERO HERMANOS DE LA MUJER:** idem
- 5a. **LUGAR DEL P.D. O DEL MARIDO EN SU FRATRIA:** 1ª, 2ª, etc.
- 5b y 5c en FF: **LUGAR HERMANOS PADRE Y MADRE DEL P.D.** (sin lugar en FF y FP)
- SEXO HERMANOS DEL MARIDO**, incluido él, p. ej.: v-v-h-v-h-v
- 6a. **ORIGEN DEL P.D.:** lugar nacimiento: Indicar provincia
- 6a. **ORIGEN DEL PADRE O MARIDO:** idem.
- 6a. **ORIGEN DE LA MADRE O MUJER:** idem.
- (Consignar en parte superior recuadro)
- | | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| 1. Alava | 2. Albacete | 3. Alicante |
| 4. Almería | 5. Avila | 6. Badajoz |
| 7. Baleares | 8. Barcelona | 9. Burgos |
| 10. Cáceres | 11. Cádiz | 12. Castellón |
| 13. Ciudad Real | 14. Córdoba | 15. Coruña, La |
| 16. Cuenca | 17. Gerona | 18. Granada |
| 19. Guadalajara | 20. Guipúzcoa | 21. Huelva |
| 22. Huesca | 23. Jaén | 24. León |
| 25. Lérida | 26. Logroño | 27. Lugo |
| 28. Madrid | 29. Málaga | 30. Murcia |
| 31. Navarra | 32. Orense | 33. Oviedo |
| 34. Palencia | 35. Palmas (las) | 36. Pontevedra |
| 37. Salamanca | 38. S. Cruz Tene | 39. Santander |
| 40. Segovia | 41. Sevilla | 42. Soria |
| 43. Tarragona | 44. Teruel | 45. Toledo |
| 46. Valencia | 47. Valladolid | 48. Vizcaya |
| 49. Zamora | 50. Zaragoza | 51. Ceuta |
| 52. Melilla | 60. Europa | 61. Asia |
| 62. Africa | 63. Hispanoam. | 64. Norteamér. |
| 65. Oceanía. | | |

6b. **RESIDENCIA ACTUAL** del P.D., Padre y Madre o Marido y Mujer. (Código como en 6a. y consignándolo en parte inferior del recuadro)

| PROCESO TERAPEUTICO | FECHAS | HECHA POR | RECIBIDA POR | OBSERVACIONES Y ORDEN MOTIVO T. PAREJA. |
|---------------------|--------|-----------|--------------|---|
| 1ª Llamada: | | | | |
| 2ª Llamada: | | | | |

Inicio TP: _____ Final TP: _____ Terapeutas: _____

SESIONES DE TPAREJA:

| Núm. | Fecha | Vídeo | Asisten | Terapeutas | Contenidos fundamentales de la sesión | Observaciones |
|------|-------|-------|---------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

CONTROLES Y SEGUIMIENTOS:

| | Cuest. STP | | | | | Cuest. A-TP (ant) | | | | | | Cuest. D-TP (Durant) | | | | | | | | | | Cuest. F-TP (Final) | | | | | | | | |
|------|------------|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Espª | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espª | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OTROS CONTROLES:

| FECHAS | RESPONDEN | EVOLUCION OBSERVADA | SITUACION ACTUAL | OBSERVACIONES |
|--------|-----------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1.6. CODIGO PARA COMPLETAR LAS FICHAS FF Y FP

(Autor: José Antonio Ríos González)

0. **REFERENCIA:** Número de orden en fichero y /año (ej: 2341/79)
1. **CASO:** Nombre del PD o de componentes de pareja: varón/mujer
- 2a. **EDAD MARIDO** en años cumplidos al consultar
- 2b. **EDAD MUJER:** idem
3. **ESTADO CIVIL:** 1. (S)oltero. 2. (C)asado canónicamente. 3. (cv) casado civilmente. 4. (V)iuído. 5. (Se)parado. 6. (P) En proceso de divorcio. 7. (D)ivorciado. 8. (Un)ión consensual-estable. 8. (O)tros.
- 4a. **NUMERO DE HERMANOS DEL P.D. O DEL MARIDO:** indicar número
- 4b y 4c en FF: **NUMERO HERMANOS PADRE Y MADRE DEL P.D.**
- 5a. **LUGAR DEL P.D. O DEL MARIDO EN SU FRATRIA:** 1ª, 2ª, etc.
- 5b y 5c en FF: **LUGAR HERMANOS PADRE Y MADRE DEL P.D.** (sin lugar en FF y FP)
- SEXO HERMANOS DEL MARIDO,** incluido él, p. ej.: v-v-h-v-h-v (idem) **SEXO HERMANOS DE LA MUJER,** incluida ella, P. ej.: v-v-v-h-h-6a. **ORIGEN DEL PADRE O MARIDO:** idem. Indicar provincia
- 6a. **ORIGEN DE LA MADRE O MUJER:** idem. (Consignar en parte superior recuadro)
1. Alava
2. Albacete
3. Alicante
4. Almería
5. Avila
6. Badajoz
7. Baleares
8. Barcelona
9. Burgos
10. Cáceres
11. Cádiz
12. Castellón
13. Ciudad Real
14. Córdoba
15. Coruña, La
16. Cuenca
17. Gerona
18. Granada
19. Guadalajara
20. Guipúzcoa
21. Huelva
22. Huesca
23. Jaén
24. León
25. Lérida
26. Logroño
27. Lugo
28. Madrid
29. Málaga
30. Murcia
31. Navarra
32. Orense
33. Oviedo
34. Palencia
35. Palmas (las)
36. Pontevedra
37. Salamanca
38. S. Cruz Tene
39. Santander
40. Segovia
41. Sevilla
42. Soría
43. Tarragona
44. Teruel
45. Toledo
46. Valencia
47. Valladolid
48. Vizcaya
49. Zamora
50. Zaragoza
51. Ceuta
52. Melilla
53. Europa
54. Asia
55. Oceanía.
60. Europa
61. Asia
62. Oceanía.
63. Hispanoam.
64. Norteamér.

6b. **RESIDENCIA ACTUAL** del P.D., Padre y Madre o Marido y Mujer. (Código como en 6a. y consignándolo en parte inferior del recuadro)

7a. OCUPACION ACTUAL DEL P.D.**7b. IDEM DEL PADRE.** (En FF: 7a: OCUPACION DEL MARIDO)**7c. IDEM DE LA MADRE.** (En FF: 7b: OCUPACION DE LA MUJER)

1. Prof. liberal. Autónomo
2. Empresario-Director-Gerente
3. Docente (indicar nivel: EGB, Media, Superior)
4. Funcionario no docente
5. Trabajador especializado
6. Trabajador no especializado
7. Técnico de grado medio
8. Ama de casa (s.l.)
9. Estudiante
10. Jubilado
11. Otra: indica cuál.

8a. ESTUDIOS REALIZADOS POR EL P.D.**8b. IDEM DEL PADRE.** (En FF: 8b: OCUPACION DEL MARIDO)**8c. IDEM DE LA MADRE.** (En FF: 8c: OCUPACION DE LA MUJER)

1. Universitarios, superiores (licenciado, doctor)
2. Perito, aparejador o ingeniero técnico
3. Maestro de enseñanza primaria
4. Otras titulaciones medias
5. Grado medio: bachiller, FP, COU
6. Estudios primarios, graduado escolar
7. Sin estudios
8. Analfabeto

9a. ESTATUS SOCIO-ECONOMICO DEL P.D.**9b. ESTATUS SOCIO-ECONOMICO DEL PADRE.** (En FF: DEL MARIDO)**9c. ESTATUS SOCIO-ECONOMICO DE LA MADRE.** (En FF: DE LA MUJER)

1. Muy alto
2. Alto
3. Medio-alto
4. Medio
5. Medio-bajo
6. Bajo
7. Muy bajo

10. SE CONOCEN. Indicar los años. (En FF no hay lugar. Anotar en genograma al dorso)**11. CASADOS, VIVEN JUNTOS desde:** Indicar años. (En FF: idem)**12. NUMERO DE HIJOS HABIDOS:** Indicar el número. (En FF: idem)**12a. EDADES ACTUALES DE LOS HIJOS:** Indicar en números y del mayor al menor; ej.: 23, 19, 13, 6. - (En FF: idem)**12b. SEXO DE LOS HIJOS HABIDOS.** del mayor al menor: así: V-V-h-V. - (En FF: idem)**13. ¿SEPARADOS?** En caso afirmativo, indicar años que hace se han separado.**14. ENVIADOS POR:**

1. Propia iniciativa del PD o de la pareja.
2. El padre del PD
3. La madre del PD
4. El marido
5. La mujer
6. Familiar del marido
7. Familiar de la mujer
8. Médico
9. Psicólogo
10. Asistente Social
11. Sacerdote
12. Institución (Escuela, Hospital, S. Sociales, etc)
13. Antiguo paciente de Stirpe
14. Familiar del marido tratado en Stirpe
15. Familiar de la mujer tratado en Stirpe
16. Otros medios (indicar cuáles)

15. MOTIVO-SINTOMA DE LA CONSULTA.

1. Abuso medicamentos
2. Adaptación, problemas de...
3. Adelgazamiento
4. Afectividad. Problemas de...
5. Agorafobia
6. Agresividad
7. Alcoholismo
8. Amenorrea
9. Angustia
10. Anorexia
11. Anorgasmia
12. Ansiedad
13. Apatía
14. Asma
15. Bulimia
16. Cefaleas
17. Ciclotimia
18. Celos infantiles
19. Celos matrimoniales
20. Claustrofobia
21. Cleptomanía
22. Complejo inferioridad
23. Conducta, problemas y trastornos
24. Conflicto conyugal
25. Conflicto con familia de origen marido
26. Conflicto con familia de origen mujer
27. Conflicto padres-hijos
28. Conflicto padre-hijo
29. Conflicto padre-hija

30. Conflicto padre-hijos
31. Conflicto madre-hijos
32. Conflicto madre-hijo
33. Conflicto madre-hija
34. Conflicto con padre
35. Conflicto con madre
36. Conflicto entre hermanos
37. Conflictos sociales
38. Conflictos en el trabajo
39. Delirios
40. Demencia
41. Dependencia neurótica
42. Depresión mayor
43. Depresión leve
44. Desarrollo. Problemas y trastornos
45. Dismenorrea
46. Divorcio emocional: crisis
47. Divorcio (pre-...): proceso ya iniciado
48. Divorcio consumado/separación real
49. Drogadicción
50. Encopresis
51. Enuresis
52. Escolaridad. Problemas y trastornos
53. Esquema corporal: conflictos con el propio...
54. Esquizofrenia catatónica
55. Esquizofrenia paranoide
56. Esquizofrenia residual
57. Exibicionismo
58. Eyacuación precoz
59. Fantasía excesiva
60. Fatiga crónica
61. Fobia
62. Fracaso afectivo
63. Fracaso escolar
64. Fracaso matrimonial
65. Fracaso noviazgo
66. Fracaso profesional
67. Fracaso vocacional
68. Frigidez
69. Fuga
70. Hipersexualidad
71. Hipersomnia
72. Hipocondría
73. Hiposexualidad (inapetencia sexual)
74. Histerismo
75. Homofobia
76. Homosexualidad
77. Hurto

78. Inadaptación afectiva
79. Inadaptación conyugal
80. Inadaptación escolar
81. Inadaptación familiar
82. Inadaptación personal
83. Inadaptación profesional/laboral
84. Inadaptación social
85. Inadaptación vocacional
86. Infidelidad conyugal
89. Incomunicación
90. Inquietud/inestabilidad
91. Inseguridad
92. Insomnio
93. Irritabilidad
94. Juego patológico
95. Lenguaje. Problemas y trastornos.
96. Malos tratos
97. Megalomanía
98. Morricidad. Problemas y trastornos
99. Mutismo electivo
100. Negativismo
101. Neurosis (indicar tipo)
102. Obesidad
103. Obsesión
104. Onicofagia
105. Paranoia
106. Paranoicismo
107. Pereza
108. Pica
109. Psicossomático. Problema y trastorno
110. Psicosis.
111. Rebelión
112. Rendimiento escolar. Problemas y trastornos
113. Retraso mental
- Separación/Ver divorcio (en 46, 47 o 48)
114. Sexualidad: aversión y rechazo
115. Sexualidad: desviación y confusión identidad
116. Sexualidad: disfunción erectiva del varón
117. Sexualidad: disfunción orgásmica de la mujer
118. Sexualidad: hipersexualidad
119. Sexualidad: vaginismo
120. Sexualidad: otros problemas: indicar cuál
121. Síndrome A.A.A. (Anorexia, adelgazamiento, amenorrea)
122. Sociopatía/conducta delincuente
123. Somatizaciones
124. Sueño. Problemas y trastornos
125. Suicidio: fantasía, intento, amenazas
126. Superdotación intelectual

- 127. Tartamudez
- 128. Temores/Miedos
- 129. Terrores nocturnos
- 130. Tics
- 131. Timidez
- 132. Tristeza
- 133. Úlcera
- 134. Vómitos
- 135. Voracidad compulsiva
- 136. Zurdía

15.1. (En FP): SINTOMAS PREVIOS (en FF no hay espacio. Anotar margen)

16. ANTIGÜEDAD DEL MOTIVO-SINTOMA: Indicar en número de años

16.1. (En FP): ANTIGÜEDAD DE SINTOMAS PREVIOS (En FF no hay espacio)

17. CONSULTAS PREVIAS REALIZADAS

- 1. Médico general
- 2. Psiquiatra
- 3. Psicólogo
- 4. Pediatra
- 5. Logopeda
- 6. Neurólogo
- 7. Endocrino
- 8. Ginecólogo
- 9. Abogado
- 10. Sacerdote
- 11. Terapia individual
- 12. Terapia de pareja
- 13. Terapia de familia
- 14. Terapia de grupo
- 15. Otros especialistas médicos: cual.
- 16. Otros tipos de terapia. Cual

17.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN CONSULTAS ANTERIORES

- 1. Óptimo. Muy bueno. Problema solucionado
- 2. Bueno, satisfactorio, estable
- 3. Regular, transitorio, inestable
- 4. Escaso, insuficiente, ineficaz
- 5. Nulo, negativo
- 6. No seguido, abandonado, sin terminar
- 7. Fracaso terapéutico

18. CICLO VITAL DE LA FAMILIA O DE LA PAREJA.

- 1. Encuentro y noviazgo ("Caza y pesca")
- 2. Matrimonio reciente (menos de 2 años)
- 3. Etapa de extensión: nacimiento de hijos
- 4. Con hijos en edad preescolar (edad del "pastoreo")
- 5. Con hijos en edad escolar
- 6. Con hijos adolescentes: extensión completa. Crisis por la presencia de las características de la etapa evolutiva

- 7. Con hijos en edad juvenil: pre-contracción
- 8. Etapa de contracción: hijos que despegan gradualmente
- 9. Pseudocontracción completa: el "nido repleto" de hijos adultos que viven como tales junto a los padres
- 10. Contracción completa: el "nido vacío", hijos fuera
- 11. Etapa de disolución: jubilación
- 12. Pareja sin hijos
- 13. Familia monoparental: no conyugalidad, viudez, separación,

19. QUIEN PIDE LA CONSULTA.

- 1. El padre del PD
- 2. La madre del PD
- 3. El marido
- 4. La mujer
- 5. Ambos cónyuges de común acuerdo
- 6. Un hermano del PD
- 7. Una hermana del PD
- 8. Abuelo paterno
- 9. Abuela paterna
- 10. Abuelo materno
- 11. Abuela materna
- 12. Un profesional. Indicar cuál.

20. ACTITUD DEL SISTEMA CONVUGAL O FAMILIAR ANTE CONSULTA

- 1. Positiva, colaboradora, aceptación
- 2. Resistente, forzada
- 3. Ambivalente
- 4. Escasamente colaboradora
- 5. Contraria, descalificadora
- 6. Rechazo total. No la acepta.

21. MOTIVACION DE QUIEN PIDE LA CONSULTA.

- 1. Clara y bien definida: sabe lo que quiere y lo pide
- 2. Ambigua: no está muy seguro/a de lo que quiere
- 3. Forzada: porque se lo han aconsejado
- 4. No sabe bien lo que quiere
- 5. Nula. Viene obligado/a por circunstancias. Resistente
- 6. Duda ante condiciones de contrato y metodología. Crítica las condiciones del contrato terapéutico.

22. TIPO DE APERTURA DEL S.F. O CONVUGAL: MODELO DEL SISTEMA.

- 1. Morfogénético espontáneo
- 2. Morfogénético forzado
- 3. Ambivalencia morfogénesis-morfostasis
- 4. Morfostasis consensuada, acordada
- 5. Morfostasis rígida.

23. ESTRUCTURA DINÁMICA FAMILIAR O CONVUGAL.

- 23.1. CRISIS FAMILIAR O CONVUGAL.
 - 1. Por factores personales
 - 2. Por factores relacionales

3. Por factores del contexto
4. Por factores transitorios/de situación
5. Tensión padres-hijos
6. Tensión con FF. de OO.
7. Tensión entre hermanos
8. Crisis o pre-divorcio
9. Divorcio en trámite
10. Post-divorcio
11. Por enfermedad física
12. Por enfermedad psíquica
13. Por embarazo
14. Por muerte
15. Otras causas: indicar cuáles.

23.2. CLIMA CONYUGAL-FAMILIAR

(Medido a través del FES (Moos). Media total de la familia o la pareja en cada escala. O en el recuadro indicar la puntuación de cada miembro).

1. Cohesión
2. Expresividad
3. Nivel de conflicto
4. Grado de autonomía
5. Actividad
6. Intereses culturales
7. Activ. socio-recreativa
8. Moral-religioso
9. Orden
10. Control

23.3. D.A.S. PAREJA (Medido a través del Spaniers)

(Sólo en FP) (En FF el 23.3 es la Comunicación).

- Puntuación de cada esposo:
1. Consenso
 2. Satisfacción
 3. Expresión afectiva
 4. Cohesión
 5. Ajuste total de pareja

23.3. y 23.4. TIPO DE COMUNICACION PREVALENTE.

(En FF: 23.3 a; En FP: 23.4 a)

1. Verbal, directa, de contenido, digital
2. No verbal, codificada, de relación, analógica

23.3. y 23.4. NIVEL DE COMUNICACION PREVALENTE.

(En FF: 23.3 b; En FP: 23.4 b)

1. Informativo
2. Formativo-manipulativo
3. Profundo-emocional
4. Doble vínculo
5. Incomunicación

23.5. en FP. DECISIONES EN COMUN

(En FF no figura este epígrafe)

23.4. en FF y 23.6 en FP. EMOCION EXPRESADA (E.E.)

1. Baja
2. Media
3. Alta

23.5 en FF y 23.7 en FP. ESTILO AFECTIVO

1. Apoyo emocional y afectivo
2. Apoyo ambivalente
3. Actitud crítica ante afectividad
4. Culpabilización de lo afectivo
5. Intrusismo/invasión en la vida afectiva
6. Simbiosis negativa
7. Rechazo afectivo
8. Incapacidad expresión sentimientos y afectos.
9. Frialidad, indiferencia.
10. Anafectividad (carencia de afectos)

23.6 en FF y 23.8 en FP. ESTILO DE APOYO

1. Apoyo estimulante-positivo y expresado
2. Entendimiento empático no expresado
3. Apoyo ambivalente
4. Apoyo en solución de problemas
5. Apoyo en búsqueda de objetivos
6. Indiferencia ante necesidad de apoyo
7. Rechazo a toda petición de apoyo

23.7 en FF. ESTILO DE AUTORIDAD

1. Estimulante hacia la independencia creadora
2. Autoritarismo estable
3. Autoritarismo inestable
4. Hiperprotección limitante
5. Carencia y ausencia de autoridad
6. Manipulación autoritaria

23.8 en FF. ESTILO DE DISCIPLINA

1. Equilibrada y maduradora
2. Caprichosa y ambivalente
3. Indiferente
4. Rígida, severa, restrictiva
5. Perfeccionista
6. Indulgente, permisiva
7. Protectora e infantilizante
8. Carencia/ausencia de disciplina

23.9 en FP. ESTILO DEFENSIVO

1. Inteligente y eficaz (situación como "problema")
2. Controlador
3. Dogmático, inflexible, rígido
4. Sublimación e idealización

5. Evasión
6. Negación de la realidad.
7. Somatización histórica ante problemas (situación vivida como "amenaza").

23.9 en FF. **ESTILO EDUCATIVO**

1. Equilibrado, constructivo y adecuado
2. Hiperprotección indulgente
3. Hiperprotección represiva
4. Insuficiente
5. Frustrante
6. Traumatizante
7. Inestable y ambivalente
8. Rígida y perfeccionista
9. Exigente
10. Tensión familiar con influjo negativo
11. Carencia, ausencia de estilo educativo
12. Abandono educativo

23.10. en FF y en FP. **ESTILO DE INDIVIDUACIÓN Y APOYO DE IDENTIDAD PERSONAL**

1. Estimulante y facilitadora de la indiv./identidad
2. Ambivalente ante la individuación e identidad
3. Inhibidora y bloqueante de la indiv./identidad
4. Rechazo de la individuación y la identidad

23.11. en FF y en FP. **ESTILO INTERACTIVO**

1. Positivo, adecuado y estimulante
2. Alta EE (Emoción Expresada): ver 23.4 y 23.6
3. Simbiosis acaparadora
4. Deficiente y limitante
5. Ausente y nulo.

23.12. en FF **ESTILO PARENTAL**

1. Jerarquización bien definida y clara
2. Constantemente compartido por ambas figuras
3. Constantemente ambivalente
4. Estilo que descalifica al padre
5. Estilo que descalifica a la madre
6. Predominio del padre (F. patrifocal)
7. Predominio de la madre (F. matrifocal)
8. Carencia real de la figura paterna
9. Carencia "virtual" de la figura paterna
10. Carencia real de la figura materna
11. Carencia "virtual" de la figura materna
12. Carencia de estilo parental bien definido
13. Jerarquización confusa de atribuciones
14. Estilo paterno negativo y destructivo
15. Estilo materno negativo y destructivo

23.13 en FF y 23.12 en FP. **ESTILO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.**

1. Acuerdos tras aceptación del problema
2. Valoración de los datos del problema: actitud inteligente y adaptada
3. Intentos de solución por tanteo y error
4. Utilización del humor/desdramatización
5. Solución mediante imposición de órdenes
6. Quejas, llanto...: actitud emocional ante el problema
7. Somatización ante tensión por el problema
8. Mecanismos varios de defensa
9. Huida/evasión de la realidad ante problema
10. No respuesta/inhibición y bloqueo
11. Puro charlar y nada concluir
12. Negación del problema/realidad
13. Carencia de habilidades resolutivas
14. Comunicación distorsionada/patológica del problema
15. Agresividad hacia el entorno (extrapunividad)
16. Agresividad hacia sí mismo (intrapunividad)
17. Sublimación del problema (arte, religión, etc.)

23.14 en FF. **ESTILO DE CONTEXTO ESTIMULANTE DEL DESARROLLO PERSONAL.**

1. Estimulos cognitivos para el desarrollo
2. Estimulos afectivos para el desarrollo
3. Inhibidores cognitivos del desarrollo
4. Inhibidores afectivos del desarrollo

23.15 en FF y 23.13 en FP. **FIDELIDADES EN EL S.F Y EN LA PAREJA.**

1. Normales, conscientes y asimiladas
2. Al clan/tribu familiar de origen (SFO)
3. Al padre
4. A la madre
5. A valores familiares no asimilados
6. A mitos y tradiciones impuestas en el SFO
7. Al estilo educativo del SFO
8. A reglas/pautas/normas del SFO

23.16. a) y b) en FF. **FIGURAS PARENTALES.**

1. P. positivo-estimulante-cercano emocionalmente
2. M. " "
3. P. frío y distante. Carencia de expresividad
4. M. fría y distante. Carencia de expresividad
5. P. ansioso
6. M. ansiosa
7. P. intrusivo/invasor/asfixiante
8. M. intrusiva/invasora/asfixiante
9. Carencia real del P. por muerte
10. Carencia real de la M. por muerte

11. P. virtualmente ausente
 12. M. virtualmente ausente
 13. P. educativamente periférico
 14. M. educativamente periférica
 15. P. hiperprotector
 16. M. hiperprotectora
 17. P. rígido/exigente
 18. M. rígida/exigente
 19. P. perfeccionista
 20. M. perfeccionista
 21. P. aislado de la vida familiar
 22. M. aislada de la vida familiar
 23. P. autoritario
 24. M. autoritaria
 25. P. educativamente abandonónico
 26. M. educativamente abandonónica
 27. P. adoptante
 28. M. adoptante
 29. P. conflictivo/creador de tensiones
 30. M. conflictiva/creadora de tensiones
 31. P. con rasgos patológicos/trastornos psíquicos
 32. M. con rasgos patológicos/trastornos psíquicos
 33. Privación temporal/ocasional del P.
 34. Privación temporal/ocasional de la M.
 35. Privación constante del P.
 36. Privación constante de la M.
- 23.17-a) en FF y 23.14 en FP: **RELACION CON FF.OO.**
(distinguir la del P/Marido y la de la M/Mujer)
1. Sana/independiente/límites claros
 2. Confusión de límites y fronteras
 3. Relación controlada/defensiva
 4. Escasos límites y fronteras
 5. Excesiva dependencia/invasión de límites
 6. Absorvente/simbólica/dominante.
- 23.17-b) en FF y 23.14 en FP: **MIEMBROS INTRUSIVOS DE LAS FF.OO.**
(distinguir la del P/Marido y la de la M/Mujer)
1. Padre
 2. Madre
 3. Hermano/s
 4. Hermana/s
 5. Tíos paternos
 6. Tíos maternos
 7. Instituciones/grupos significativos para la F.
- 23.18 en FF y 23.15 en FP: **LÍMITES EMOCIONALES ENTRE LOS MIEMBROS EN LA FAMILIA O LA PAREJA.**
1. Adecuados/claros/definidos: "puertas cerradas"
 2. Confusos: "puertas abiertas"

3. Limitantes de la intimidad personal
 4. Limitantes de la intimidad conyugal
 5. Rígidos
 6. Inexistentes. No hay límites
- 23.19 en FF y 23.16 en FP: **LÍMITES FÍSICOS/TERRITORIALES DE LOS MIEMBROS EN LA VIVIENDA.**
1. Adecuados/claros/definidos: "Puertas cerradas"
 2. Confusos/invasión de unos en otros: "puertas abiertas"
 3. Limitantes de la intimidad personal
 4. Limitantes de la intimidad conyugal
 5. Rígidos
 6. Inexistentes. No hay espacios propios.
- 23.20 en FF y 23.18 en FP: **MIEMBROS SINTOMÁTICOS EN FAMILIA O PAREJA.**
1. Ninguno
 2. Padre/Marido
 3. Madre/Mujer
 4. Abuelo paterno
 5. Abuela materna
 6. Abuelo materno
 7. Abuela materna
 8. Hijo (no el PD)
 9. Hija (no el PD)
 10. Tío/a paterno
 11. Tío/a materno
 12. Otros (indicar cuáles)
- 23.21 en FF y 23.19 en FP: **ANTECEDENTES SINTOMÁTICOS EN MIEMBROS FF.OO.**
1. Ninguno
 2. Trastornos en la infancia
 3. Trastornos en la adolescencia/juventud
 4. Enfermedades crónicas
 5. Alcoholismo
 6. Drogodependencias
 7. Sida
 8. Trastornos afectivos
 9. Trastornos psicossomáticos
 10. Inadaptación escolar/académica
 11. " " laboral
 12. " " familiar
 13. " " conyugal
 14. " " social
 15. Otros: Indicar cuáles.

23.22 en FF y 23.20 en FP: MITO FAMILIAR/CONYUGAL DOMINANTE.

1. Armonía
2. Disculpa/redención
3. Salvación/protección
4. Unidad familiar hasta que...
5. Felicidad familiar hasta que...
6. Normalidad familiar hasta que...
7. Capaces de...
8. Incapaces de...
9. Hijo/a parecido/a a...
10. Hijo/a que ha heredado de...
11. Quien es quien en la familia: atribuciones.

23.23 en FF y 23.21 en FP: PODER EN LA FAMILIA/PAREJA

1. Compartido entre padres/cónyuges
2. Reparto consensuado abiertamente/explicitamente
3. Poder paterno/marido
4. Poder materno/mujer
5. Poder centrado en un hijo: hijo genitorial
6. Poder centrado en el PD.
7. Poder centrado en FO del padre/marido
8. Poder centrado en FO de la madre/mujer
9. Ambigüedad
10. Competitividad conflictiva por áreas
11. Oculto, pero real y discutido
12. Impuesto despoticamente
13. No existe poder claro: caos, anarquía
14. Depositado en figura significativa no familiar

23.24 en FF y 23.22 en FP: RED SOCIAL DE LA FAMILIA/PAREJA

1. Excelente y de buen apoyo
2. Buena y suficiente
3. Suficiente salvo en situaciones de estrés
4. Media
5. Limitada/escasa
6. Insuficiente
7. Nula

23.25 en FF y 23.24 en FP: REGLAS EN LA FAMILIA/PAREJA

1. Explícitas/reconocidas
2. Implícitas
3. Secretas
4. Metarreglas
5. Sin reglas

23.26 en FF y 23.25 en FP: ROLES EN LA FAMILIA/PAREJA

- A. Claridad
1. Claros y definidos
2. Indefinidos
3. Confusos

B. Distribución

1. Complementaria: cada uno a uno
2. Simétrica: todos a todo
3. Conflictiva
4. Imprevista
5. Sin distribución
6. Abandono de los atribuidos
7. Rechazo de los asignados. No se acepta ninguno.

23.26 en FP: SEXUALIDAD EN LA PAREJA

(Medido a través del SF-82 de J.A. Ríos)

1. INICIO:
 - 1.1. Inicio marido
 - 1.2. Inicio mujer
 - 1.3. Inicio mutuo acuerdo
 - 1.4. Inexistencia/inapetencia

2. MOTIVACION:

- 2.1. Apecece a ambos
- 2.2. Apecece al marido y la mujer acepta
- 2.3. Apecece a la mujer y el marido acepta
- 2.4. Obligación aceptada sin convencimiento
- 2.5. Por compasión o pena hacia el marido
- 2.6. Por compasión o pena hacia la mujer
- 2.7. Por conseguir una mayor unidad de pareja
- 2.8. Por aliviar o resolver tensiones y problemas
- 2.9. Por verdadera comunicación de afecto y amor

3. SATISFACCION:

- 3.1. Buena y estable
- 3.2. Buena aunque inestable
- 3.3. Insatisfactoria e inestable
- 3.4. Estable e insatisfactoria
- 3.5. Inestable e insatisfactoria
- 3.6. Nula

4. ESTABILIDAD:

- 4.1. Buena
- 4.2. Regular
- 4.3. Escasa
- 4.4. Nula

5. DISFUNCION:

- 5.1. Ninguna
- 5.2. Alguna (indicar cual)
- 5.3. Varias (indicar cuáles)

23.27 en FF y 23.28 en FP: TIEMPO LIBRE EN LA FAMILIA/PAREJA

1. Satisfactorio por adecuado al ciclo vital o necesidades profundas de cada miembro de la familia o pareja (familia y pareja complementaria)
2. Equilibrio por aceptación de tiempo libre y compartido cuando hay motivos

3. Conflicto por imposición inadecuada al ciclo vital de cada miembro de la familia o pareja (familia o pareja simétrica)
4. Todo el tiempo libre compartido. Asfixiante.

23.28 en FF y 23.29 en FP: **VALOR DOMINANTE EN LA FAMILIA/PAREJA**

1. Intelligencia/estudios/saberes
2. Salud
3. Comida
4. Dinero
5. Religión
6. Política
7. Sociedad
8. Lo estético
9. Orden/normas/horarios
10. Respeto
11. "Quedar bien ante los otros"
12. No hay ningún valor dominante claro
13. Otros: indicar cuáles.

23.29 en FF, y 23.30 en FP: **TIPO DE FAMILIA Y PAREJA**

Familia:

1. Por estabilidad, cohesión y progreso:

1. Sana
2. Fóbica
3. Obsesiva
4. Histérica
5. Ansiosa
6. Anafectiva
7. Neurótica/"enferma"/dysfuncional
8. Psicossomática
9. "Que hace enfermar"

2. Por la figura central:

1. Matrifocal
2. Patrifocal
3. Centrada en el PD
4. Centrada en otro miembros del SF: cual.
5. Equilibrada
6. Hijo genitorial
7. Abuelo paterno
8. Abuela paterna
9. Abuelo materno
10. Abuela materna
11. Monoparental (cuando falta el P. o M.)

3. Por distunciones o tipología del PD.

1. Normal
2. Restrictiva
3. Autista
4. Esquizofrenógena
5. Anorexigena

6. Obesígena
7. Normativa
8. Con comunicación de dirección de los otros
9. De comunicación tradicional
10. Alcohólica
11. Drogodependiente
12. Delictiva
13. Psicossomática

4. Por el modelo estructural (OTF, 518)

1. Abierto-integrado
2. Parcialmente abierto-integrado
3. Abierto-bastante integrado
4. Parcialmente abierto-bastante integrado
5. Parcialmente abierto-pseudointegrado
6. Cerrado-pseudointegrado
7. Cerrado-integrado
8. Parcialmente abierto-no integrado
9. Sensible al ambiente (OTF, 522)
10. Sensible a la distancia interpersonal
11. Sensible al consenso

5. Por distancia emocional (OTF, 486)

1. Familia "distante"
2. Familia "simétrica"
3. Familia "complementaria"

6. Modelo de Minuchin (M) y Canavaro (C)

1. Aglutinada (M)
2. Laxa (M)
3. Cohesiva (C)
4. Dispersiva (C)

Pareja: (Ríos G., 1979-1980: Educadores núm. 105, 106, 107, 109, 110)

1. Por la estabilidad de la relación:

1. Estable-insatisfactoria
2. Inestable-insatisfactoria
3. Inestable-satisfactoria
4. Estable-satisfactoria

2. Por las reglas de la relación:

1. Pareja con reglas reconocidas
2. Pareja con reglas implícitas
3. Pareja con reglas secretas
4. Pareja con metareglas
5. Pareja sin reglas

3. Por el tipo de sistema conyugal:

1. Pareja con sistema conyugal abierto
2. Pareja con sistema conyugal cerrado

4. *Por la historia curricular de la pareja:*

1. Pareja A
2. Pareja H
3. Pareja O
4. Pareja S
5. Pareja V
6. Pareja X
7. Pareja Y
8. Pareja I

5. *Por el comportamiento sintomático:*

1. Pareja tóxica
2. Pareja histeroide
3. Pareja esquizoide
4. Pareja epileptoide

6. *Por la dinámica evolutiva de los partners:*

1. Pareja con fijaciones evolutivas (orales, anales, fáticas)
2. Pareja con regresiones evolutivas
3. Pareja con estabilidad-madurez-progresión evolutiva

7. *Por el tipo de relación:*

1. Pareja con relación objetal
2. Pareja con relación objetiva

8. *Por el nivel de la relación:*

1. Pareja adulto-niña
2. Pareja adulta-niño
3. Pareja niño-niña
4. Pareja adulto-adulta

9. *Por las metas de la comunicación:*

1. Pareja con comunicación "informativa"
2. Pareja con comunicación "manipulativa-formativa"
3. Pareja con comunicación "profunda"

10. *Por el tipo de "troquelado"*

1. Pareja de troquelado simétrico
2. Pareja de troquelado complementario
3. Pareja de troquelado distante/distanciamiento
4. Pareja de troquelado igualatorio

23, 30 en FF y 23, 27 en FP: **ESTRES: GRADO Y AGENTES.**

Grado:

1. Muy alto
2. Alto
3. Medio
4. Bajo
5. Muy bajo

Agentes:

1. Conflicto conyugal
2. Pre-divorcio
3. Divorcio/separación real
4. Malos tratos
5. Violencia
6. Enfermedad crónica de un miembro
7. Enfermedad ocasional grave
8. Trastorno psíquico grave
9. Idem ocasional
10. Inestabilidad laboral
11. Paro
12. Accidente
13. Marginación/delinuencia
14. Emigración (inadaptación por...)
15. Inmigración (inadaptación por...)
16. Cáncer
17. Prostitución
18. Drogadicción
19. Alcoholismo
20. Sida
21. Muerte familiar cercano
22. Muerte amigo
23. Expulsión de colegio
24. Fracaso sentimental
25. Salida del hogar de algún miembro
26. Violación
27. Padre ausente
28. Madre ausente
30. Embarazo imprevisto hija
31. Problemas económicos graves
32. Infidelidad conyugal
33. Cambio de casa, piso, residencia, ciudad
34. Tensión laboral o profesional
35. Fracaso estudios
36. Fracaso negocio/laboral
37. Otros: indicar cuáles.

1.7. MODELOS DE FICHAS PARA LA SESION DE FAMILIA (SF) Y SESION DE PAREJA (SP)

1.7.1. FICHA SF

(Completar con bolígrafo de punta fina y letra clara/legible)

SF

| | | | | | |
|---|------|-----------|------------|-----------------|--|
| PAREJA | | MADRE | | PADRE | |
| ASISTEN: | | FALTAN | | MOTIVOS FALTAS: | |
| 1. HIPOTESIS PRE-SESION: | | | | | |
| 2. PUNTOS A TRABAJAR EN SESION: (T=Trabajado/NT=No trabajado) | | | | | |
| (C=Confirmada/MC=No Confirmada) | | | | | |
| FAMILIA | | TERAPISTA | | | |
| Ref | Edad | Fecha | Se aplaza? | Terapeuta: | |
| Init | Vld. | Grupo | | | |
| 3. EVOLUCION DEL MOTIVO/SINTOMA: | | | | | |
| C=Cambio +Mejoria. I=Igual. P=Peor. | | | | | |
| Observaciones: | | | | | |
| 4. NUEVOS SINTOMAS EN QUIEN | | | | | |
| 5. NUEVOS PACIENTES | | | | | |
| 6. NUEVOS SUBSISTEMAS | | | | | |
| 7. NUEVAS ALIANZAS. | | | | | |
| 8. NUEVAS TRIANGULACIONES: | | | | | |
| 9. ENFRENTAMIENTOS: | | | | | |
| 10. EVOLUCION DE LA INTERACCION FAMILIAR: | | | | | |
| C=Cambio+/Mejor. I=Igual. P=Peor. | | | | | |
| Observaciones: | | | | | |
| 11. COLABORACION MIEMBROS EN T.F. Padre | | | | | |
| Hijo | | | | | |
| Hijo | | | | | |
| Hijo | | | | | |
| 12. CUMPLIMIENTO PRESCRIPCIONES SESION ANTERIOR: 1. | | | | | |
| Hijo | | | | | |
| Hijo | | | | | |
| Hijo | | | | | |
| 14. ACTITUD MIEMBROS ANTE PRESCRIP. P: | | | | | |
| (P)ositiva (N)egativa (I)ndifer/ | | | | | |
| (O)ignora (D)escalitica (D)uda. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| PROXIMA SESION: Dia | | | | | |
| Hora | | | | | |
| Asistiran: | | | | | |
| Otros acuerdos: | | | | | |

Modelo Ficha Ter.Familiar. JAROS/1991. (Prohibida repr. sin citar autor)

(Completar con bolígrafo de punta fina y letra clara/legible)

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| Verbal | P | M | PD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| No Verbal | | | | | | | | | |
| Com. Infor. | | | | | | | | | |
| Manipulat. | | | | | | | | | |
| Profunda | | | | | | | | | |

19. COMUNICACION PREDOMINANTE EN LA SESIÓN.

15. Fidelidad SP

14. cont. desarr.

13. sol. problem.

12. parental

11. interactiv

10. interactiv

9. educación

8. disciplina

7. autoridad

6. apoyo

5. estilo afectivo

4. Emoc. expresada

3. Nivel

2. Comunicación: Tipo

1. CN

52 SR

51 AC

41 AU

40 CT

39 EX

38 CM

37 CR

36 CA

35 CC

34 CC

33 CC

32 CC

31 CC

30 CC

29 CC

28 CC

27 CC

26 CC

25 CC

24 CC

23 CC

22 CC

21 CC

20 CC

19 CC

18 CC

17 CC

16 CC

15 CC

14 CC

13 CC

12 CC

11 CC

10 CC

9 CC

8 CC

7 CC

6 CC

5 CC

4 CC

3 CC

2 CC

1 CC

20. EMOCION EXPRESADA (EE) EN LA SESIÓN

Coment. Crít.

Hostilidad

Impl. Emot.

Resumen hecho por

del Grupo

Curso

29. Tipo Fam.

Observaciones:

1. V

2. V

3. V

4. V

5. V

6. V

7. V

8. V

9. V

10. V

11. V

12. V

13. V

14. V

15. V

16. V

17. V

18. V

19. V

20. V

21. V

22. V

23. V

24. V

25. V

26. V

27. V

28. V

29. V

30. V

31. V

32. V

33. V

34. V

35. V

36. V

37. V

38. V

39. V

40. V

41. V

42. V

43. V

44. V

45. V

46. V

47. V

48. V

49. V

50. V

51. V

52. V

53. V

54. V

55. V

56. V

57. V

58. V

59. V

60. V

61. V

62. V

63. V

64. V

65. V

66. V

67. V

68. V

69. V

70. V

71. V

72. V

73. V

74. V

75. V

76. V

77. V

78. V

79. V

80. V

81. V

82. V

83. V

84. V

85. V

86. V

87. V

88. V

89. V

90. V

91. V

92. V

93. V

94. V

95. V

96. V

97. V

98. V

99. V

100. V

1.7.2. FICHA SP

Manual de Orientación y Terapia Familiar

(Completar con bolígrafo de punta fina y letra clara/legible)

| | | | |
|--|--|----------|--|
| MARIDO: / | | MUJER: / | |
| 1. HIPÓTESIS PRE-SESIÓN: | | | |
| 2. PUNTOS A TRABAJAR EN SESIÓN: (T=Trabajado, NT=No Trab) | | | |
| 3. EVOLUCIÓN MOTIVO/SINTOMA: | | | |
| C=Confirmada, NC=No Confirmada. | | | |
| P=Peor, C=Cambio+/mejora, I=Igual | | | |
| Observaciones: | | | |
| 4. NUEVOS SINTOMAS EN QUIEN: | | | |
| 5. NUEVOS SUBSISTEMAS: | | | |
| 6. NUEVAS ALIANZAS: | | | |
| 7. N. TRIANGULACIONES: | | | |
| 8. ENTRENAMIENTOS: | | | |
| 9. EVOLUCIÓN DE LA INTERACCIÓN CONYUGAL: | | | |
| C=Cambio+/mejor, I=Igual, P=Peor. | | | |
| 10. COLABORACIÓN CONYUGES EN TERAPIA. Marido: | | | |
| 11. CUMPLIMIENTO PRESCRIPCIONES SESIÓN ANTERIOR: 1. / 2. / 3. / | | | |
| 12. CONNOTACIONES EN SESIÓN: | | | |
| 13. REDEFINICIONES EN SESIÓN: | | | |
| 14. PRESCRIPCIONES DADAS EN ESTA SESIÓN: | | | |
| 15. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (DORSO): | | | |
| 16. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (VISO): | | | |
| 17. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 18. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 19. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 20. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 21. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 22. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 23. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 24. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 25. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 26. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 27. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 28. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 29. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 30. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 31. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 32. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 33. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 34. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 35. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 36. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 37. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 38. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 39. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 40. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 41. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 42. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 43. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 44. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 45. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 46. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 47. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 48. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 49. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 50. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 51. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 52. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 53. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 54. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 55. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 56. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 57. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 58. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 59. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 60. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 61. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 62. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 63. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 64. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 65. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 66. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 67. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 68. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 69. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 70. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 71. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 72. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 73. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 74. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 75. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 76. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 77. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 78. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 79. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 80. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 81. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 82. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 83. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 84. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 85. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 86. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 87. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 88. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 89. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 90. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 91. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 92. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 93. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 94. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 95. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 96. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |
| 97. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (LATERAL): | | | |
| 98. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (FRONTAL): | | | |
| 99. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (POSTERIOR): | | | |
| 100. PROCESO EVOLUTIVO de la pareja según se observa (ANTERIOR): | | | |

Mod. Ficha Ter.Pareja. JAR/1991 (Prohibida reproducción sin citar autor)

(Autor: José Antonio Ríos González)

Quinn's father

Motivos de la falta: Breve síntesis de las causas de ausencia de algún miembro de la familia.

Recuadro: Familia ... Ref:.... Matrimonio... Ref:....
Sesión n.º (con esta familia) Fecha ... Ref:....

¿Se aplazó? A fin de ver las oscilaciones, abandonos, interrupciones, etc. y fecha en que estuvieron citados.

En la SP: Asisten:.... Terapeutas:....

1. Hipótesis pre-sesión: Se registran las 2/3 hipótesis que formula el equipo con vistas a que sirvan de guía para la sesión que va a celebrarse.

En la post-sesión se registrará si han sido confirmadas (C) o no confirmadas (NC) a fin de tenerlo en cuenta para el proceso terapéutico posterior.

2. Puntos a trabajar en la sesión: Aparte de las hipótesis formuladas en el epígrafe anterior, deberán consignarse algunos puntos o temas concretos que sea útil abordar en la sesión. El tenemos previstos, con independencia de que posteriormente la dinámica de la sesión permita o no abordarlos, es útil para saber "por dónde ir", sobre todo cuando la familia maneja sus armas para contrarrestar, anular, bloquear o eludir lo que es más terapéutico y, por ello, más doloroso de afrontar.

¿En qué medida se consignará en la ficha si cada tema previsto se ha trabajado (T) o no (NT), y que esto facilita el control de los temas que van siendo? ¿...

3 Evolución del "no" en los niños que van siendo educados o no afrontados.

5. Evolución del motivo/síntoma: Se reservan espacios suficientes para consignar hasta 5 motivos o síntomas que constituyen el eje central de las preocupaciones de la familia. Los terapeutas han de ir valorando sesión a sesión qué cambios se verifican en este nivel. Para ello, junto al síntoma hay un espacio para anotar los cambios positivos/mejoría (C), la permanencia en el mismo nivel (I= igual) o el empeoramiento (P), pudiendo añadir alguna observación pertinente que no sea posible registrar en los espacios anteriores.

3.2. nuevos síntomas y nuevos pacientes: Obedecan estos epígrafes a la convención de anotar los "nuevos síntomas" que pueden aparecer, ya sea en el mismo PD o en cualquier otro miembro de la familia ("en quién"). La frecuencia con que se presenten estos fenómenos en bastantes familias, hace convenientemente tenerlo en cuenta para tomar buena nota de ello, dado que es una manifestación de cómo la familia necesita tener siempre algún síntoma que le permita mantener un nivel de estabilidad (homeostasis), aunque sea tan precario. La aparición de nuevos síntomas es una señal de alarma para

| 15. PROCESO EVOLUTIVO DE LA PAREJA SEGUN SE OBSERVA EN LA SESION n° | | Fecha | | Video | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------|--|-----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| CAMBIOS DE ESPACIO EN LA SESION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicio sesión: Hora: | | Primer cambio: Minuto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segundo cambio: Minuto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVOLUCION GLOBAL OBSERVADA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>OR.</td><td></td></tr> <tr><td>SR.</td><td></td></tr> <tr><td>AC.</td><td></td></tr> <tr><td>CT.</td><td></td></tr> <tr><td>CO.</td><td></td></tr> </table> | | OR. | | SR. | | AC. | | CT. | | CO. | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>CN.</td><td></td></tr> <tr><td>MR.</td><td></td></tr> <tr><td>IC.</td><td></td></tr> <tr><td>AU.</td><td></td></tr> <tr><td>EX.</td><td></td></tr> </table> | | | CN. | | MR. | | IC. | | AU. | | EX. | |
| OR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AU. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EX. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) FRS del SFC (15.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Valoración aproximada) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>9.</td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> <tr><td>1.</td><td></td></tr> </table> | | 9. | | 7. | | 5. | | 3. | | 1. | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> </table> | | | 10 | | 8. | | 6. | | 4. | | 2. | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.25. Sexualidad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.26. Stress cony. Grado: Agentes: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.27. Tiempo libre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.28. Valor domín. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.29. Tipo Pareja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. Crisis/cisma conyugal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. Cima familiar (FRS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3. D.A.S. (32) Consenso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) Expresión afectiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (12) Cohesión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (75) Ajuste total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4. Comunicación: Tipo: Nivel: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5. Decisiones en común : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6. Emoción expresada-RE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.7. Estilo afectivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.8. " de apoyo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.9. " defensivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.10. " individualización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.11. " interactivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.12. " solución probl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.13. Fidelidades Sub.Cony. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.14. FO: Relaciones con... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15. Límites emocionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.16. Límites físicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.17. Límites con FF.OO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.18. Miembro sintomático | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.19. Anteced. " " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.20. Mito de pareja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.21. Poder en la pareja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.22. Red social de pareja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.23. Reglas de pareja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.24. Roles conyugales. Clar: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribución: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| =Resumen hecho por | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

que el terapeuta trabaje ayudando a que el equilibrio no se haga a base de crear "nuevos pacientes". Marcarán nuevos caminos del trabajo a realizar. De lo contrario tendremos siempre en juego el tipo de "familia que hace enfermar" y que cronifica las situaciones disfuncionales.

En la ficha SP sólo aparece el apartado 4.

6. 7. 8. y 9. Nuevos subsistemas: Más allá de los subsistemas clásicos, podemos ir viendo cómo la misma dinámica de la terapia crea otros nuevos (6, 5 en la SP). En ello interviene, como se sabe, las nuevas alianzas (7; 6 en la SP) y la determinación de los miembros afectados, las nuevas triangulaciones (8; 7 en la SP) y los afectados por fenómenos de la interacción familiar en su crecimiento desarrollo. El registro de cada uno de estos mecanismos resulta útil para que el terapeuta y su equipo puedan tener idea clara de lo que sucede más allá de la pura sintomatología. No conviene olvidar que tras ellos se ocultan muchas maniobras de poder, control, resistencias al cambio, obtención de beneficios secundarios, etc.

Un espacio para observaciones permite completar la información recogida en la sesión.

10 (9 en la SP) Evolución de la interacción familiar: En este apartado se recogerá la información que facilite una evaluación global de la evolución de la interacción, todo ello en relación con el estado inicial al comienzo de la terapia. Se hará en términos de cambio y mejora (C), de estabilidad o igualdad de la situación (I) o de claro empeoramiento (P). Se mantiene un espacio para posibles observaciones.

11 (10 en la SP) Colaboración de los miembros/cónyuges en la Terapia: A veces dejamos de hacer un análisis de qué aporta o no aporta cada miembro del sistema familiar al esfuerzo y al trabajo que supone la misma terapia. Acostumbrados a ver "el todo" como "un sistema" nos olvidamos de sus "partes". Vemos el cuadro de Las Meninas, por ejemplo, pero no reparamos en cada uno de sus personajes como tales. Esto empuja a la visión

Por ello es necesario observar cómo colabora cada miembro: el padre, la madre, el PD, el hijo X o la hija Z o el marido y la mujer. Un simple registro (ver 14, en la SF) nos dará una rápida contemplación de cómo colabora cada cual. De cara a la formulación de connotaciones, desajustes, prescripciones, son de gran utilidad estas anotaciones.

12. (11 en la SP) Cumplimiento de las prescripciones dadas en la sesión anterior: Es evidente que muchos estancamientos y hasta abandonos de la terapia pueden residir en que las mismas familias y parejas ven que hacemos prescripciones que no cumplen sin que ocurra nada, especial por esta actitud de no-colaboración. Con demasiada frecuencia nos olvidamos de seguir la pista a lo que indicamos, haciéndonos co-responsables de tales "fracasos". Un arma contra este peligro reside en llevar un buen registro de las prescripciones dadas en el espacio que asignamos para sintetizar cada una, y un recuadro para detallar, simplemente, sí o no. Con ello podemos tener en un simple vistazo, repitido que la terapia no conduce a nada, podremos mostrarles cuántas cosas de las indicadas han realizado y cuántas no.

En nuestro equipo, aparte de la conservación en vídeo de cuanto acontece en la sesión, disponemos de una hoja-registro donde recogemos las prescripciones con toda clase de detalles. Un análisis del modo de dadas, la integración de todos los miembros en ella, y la elección del momento terapéutico para hacerlo, nos ofrece un buen instrumento para saber por qué funcionan o no las prescripciones dadas.

13 en la SF y 15 en la SP sirven para recoger aquí, por razones puramente de distribución del espacio de la ficha, los acuerdos respecto a la fecha de la próxima sesión (día y hora), quienes asistirán, y otros acuerdos que convenga anotar para mayor precisión.

14. Actitud de los miembros ante las prescripciones: Paralelamente a lo indicado en el punto anterior, dejamos constancia de la actitud ante lo prescrito. El cumplirlas o no, así como el colaborar para su realización o su bloqueo, depende mucho de la actitud básica que se adopte ante el mandato. Para conservar esta información, referida a la actitud miembro en particular, usamos los siguientes registros: (P)ositiva, (N)egativa, (I)ndiferente, (O)lignora, (D)escalifica o (d)uda

*(Este apartado no aparece en la ficha de SP)

15., 16 y 17 en la SF y 12, 13 y 14 en la SP: Son los espacios reservados para el registro de tres tipos de intervenciones estratégicas ya clásicas en la Terapia Familiar Sistémica. No entramos aquí a discutir si mantienen o no su virtualidad dentro de la inevitable evolución de los modelos de intervención según cada Escuela. Nos parecen útiles y eficaces y por ello, sin más, los mantenemos y los usamos. Tal vez el secreto de su uso y eficacia reside en saber dar un poco de cada una en el momento oportuno: una redefinición que patología a la situación, seguida de una acertada connotación que estimule lo que se hace en la familia, abre un camino real para poder prescribir con bastantes garantías de eficacia. Y sería, como se ha afirmado, un modelo de intervención magistral en terapia familiar.

Connotaciones dadas en la sesión: 15 en SF y 12 en SP: Reservamos tres líneas que nos parecen suficientes para anotar las hechas en la sesión. Es verdad que muchas veces hacemos más de tres, pero es una buena media por sesión.

Redefiniciones hechas en la sesión: 16 en SF y 13 en SP: Igualmente para tres, ya que tampoco conviene abusar de ellas en una misma sesión. Que nadie piense que sólo hay que hacer tres y siempre tres. También aquí, como en casi todo, la rigidez sería contraproducente.

Prescripciones dadas en esta sesión: 17 en SF y 14 en SP: Su registro facilita el control de ellas en la sesión siguiente tal y como se ha especificado en los puntos 12 y 13 de esta misma ficha. Es interesante resaltar que para la recogida de esta información contamos con varios apartados: a quién se da (ya que aunque una buena prescripción contenga su contenido, no hay por qué evitar dirigirla fundamentalmente a un miembro), la sesión siguiente, si se ha cumplido o no (Control).

18 en SF y 15 en SP: Proceso evolutivo de la dinámica de la Estructura Familiar y proceso evolutivo de la pareja.

Es el capítulo más extenso de ambas fichas y es paralelo al consignado en el apartado 23 de la FF y de la FP y que sirve de punto de referencia para su evaluación. Para completar cada una de estas casillas debe utilizarse el mismo Código presentado en las Fichas FF y FP.

Evidentemente no puede controlarse todo en cada sesión, pero sí es conveniente evaluar todos los aspectos que se pueda.

También es posible si el equipo mantiene ciertas dosis de disciplina científica y rigor metodológico bajo la guía de un coordinador habilidoso, condiciones que no siempre se llevan a cabo. Este cometido es una tarea que puede hacerse fuera de la sesión y posesión, y en nuestra metodología -tanto del equipo como en el proceso de nuestro

Programa de Formación de Terapeutas- esta tarea se realiza en casa. Ningún especialista, por otra parte, "hace todo" cuando tiene a su paciente delante, sino que tal cometido es un deber que hay que llevar a cabo en horas extraordinarias. Por eso también estas horas hay que contabilizarlas en la formación.

Si comparamos los epígrafes 18 de esta ficha (SF) y 23 de la (FF), encontraremos algunas diferencias en la codificación de los distintos matices o subapartados que encierra cada una de ellas. Actuando con atención se verá que no presenta dificultades especiales.

19 en la SF: Comunicación predominante en la sesión.

Reservamos un lugar especial al tema de la Comunicación, tanto en sus tipos (verbal y no verbal) como en sus niveles (informativa, manipulativa y profunda), ya que es un aspecto al que damos gran importancia en el proceso de la Terapia Familiar. Se ha reservado el espacio conveniente para registrar tanto el tipo como el nivel que utiliza preferente cada miembro de la familia: padre, madre, PD y resto de hijos. Solemos utilizar signos positivos cuando se da cualquiera de ellos en cada miembro, con lo que un simple vistazo nos muestra dónde se polariza el estilo comunicativo predominante o preferido por la familia como conjunto.

20 en la SF: Emoción Expresada (EE) en la sesión.

Le damos bastante peso al constructo EE por cuanto se ha detectado como un buen indicador de la persistencia de ciertas sintomatologías. Utilizando las categorías establecidas para su observación, recogemos en las casillas correspondientes lo que puede quedar consignado como factores que influyen para el mantenimiento de los síntomas. La ficha SP no recoge estos dos capítulos, pero han de ser tenidos en cuenta en las sesiones de pareja por las mismas razones expuestas anteriormente.

En ambas fichas aparece un lugar destacado para recoger los cambios de espacio en la sesión, teniendo presente que nos interesa anotar cómo está la familia o la pareja al inicio de la sesión y los momentos en que se introducen cambios a propuesta de alguno de los terapeutas. Un simple uso de siglas acordadas por el equipo facilita la realización de esta tarea. La recogida del momento en que se introduce el cambio (minutos en que se verifica), la hacemos con vistas a alguna investigación que nos permita encontrar nuevas pautas de intervención.

Ambas fichas recogen información acerca de quién ha hecho el resumen de la sesión conforme a la metodología expuesta, así como quién ha intervenido como supervisor, si fuese el caso.

APENDICE 2.

Cuestionarios de evaluación previa a la Terapia de Familia y Terapia de Pareja

Desde hace varios años venimos utilizando en nuestra consulta varios Cuestionarios como instrumentos de Evaluación antes de empezar la Terapia de Familia o Pareja. Tras algunos años en que prescindimos de ellos, iniciando la terapia de manera directa -tal vez como "rechazo" a tantos años anteriores en que apoyábamos casi todo nuestro trabajo en los datos acumulados mediante la aplicación de tests y resortes de diversa índole- hemos vuelto a ellos, viendo que las pistas que abren poara el inicio de la terapia son muy importantes. Por otra parte, si no tenemos un cierto "diagnóstico" inicial de las interacciones que se dan en el interior de los sistemas que abordamos terapéuticamente, malamente podremos tener un punto de referencia sobre el cual asentará la evaluación de los cambios que provoca la terapia.

La amistosa invitación del profesor Yela en el prólogo a la primera edición de esta obra, ha sido, sin duda, un estímulo para volver a centrar lo que él denominaba "tecnologías verificables". Es un paso hacia derroteros que otros irán profundizando con herramientas más finas. Pero mi gratitud a su consejo ha de quedar patente en esta segunda edición.

Aquí presentamos los instrumentos que venimos utilizando y que se nos van mostrando como inicialmente válidos para nuestro objetivo. Poco a poco los iremos comprobando para garantizar la fiabilidad en el sentido que nos interesa. Y en ello estamos y en ello seguiremos y continuarán quienes nos precedan, que ya son muchos.

2.1. CUESTIONARIOS "A-TF" y "A-TP"

Con estos dos Cuestionario denominados "A" se pretende evaluar la situación que vive la familia o el matrimonio "antes" de iniciar la Terapia que solicitan. Es una manera de recoger la impresión subjetiva que tiene cada uno de los miembros del sistema sometido a consulta, para poder tener un punto de partida sobre el que iniciar el trabajo terapéutico.

2.1.1. CUESTIONARIO A-TF ("A"ntes de la T. Familiar)

Familia:

Respuestas de:

Fecha:

Ref.:

Como información complementaria a cuanto han sometido a nuestra consideración, deseáramos nos respondiese con independencia de los demás miembros de su familia, a las preguntas siguientes, eligiendo una de las posibilidades que se le ofrecen en cada cuestión:

A.1. La situación familiar actual es:

- a. Buena
- b. Existen problemas
- c. Es francamente mala
- d. Es muy mala

A.2. El problema que consultamos se centra en:

- a. Los padres
- b. Afecta a todos
- c. Afecta a un hijo (indique su nombre:)
- d. Afecta a una hija (idem:)
- e. Afecta al padre
- f. Afecta a la madre

A.3. Lo que yo espero de "Stirpe" es:

- a. Que nos ayuden a solucionar la situación
- b. Que nos solucionen todo en "Stirpe"
- c. No espero nada

A.4. La invitación a que acudamos todos a la terapia:

- a. Me ha parecido la mejor forma de abordar la situación
- b. Me sorprende agradablemente
- c. Me produce curiosidad
- d. La acepto sin plantearme ningún problema
- e. Me deja indiferente
- f. Me sorprende negativamente y la rechazo

A.5. Antes de venir a "Stirpe", pienso que la raíz de nuestros problemas está:

- a. En toda la familia
- b. En una parte de la familia
- c. Sólo quien aparece como "paciente"
- d. Fuera de todos nosotros
- e. En:

A.6. Si quiere añadir algo sobre la situación familiar que van a consultar, puede hacerlo a continuación:

Firma:

2.1.2. CUESTIONARIO "A-TP" ("A"ntes de la Terapia de Pareja)

Matrimonio:

Respuestas de:

Fecha:

Ref.:

Como complemento a cuanto someten a nuestra consulta, deseamos nos responda personalmente a las cuestiones siguientes, eligiendo una de las alternativas que se ofrecen para cada pregunta:

A.1. La situación matrimonial actual es

- a. Buena
- b. Existen problemas
- c. Es francamente mala
- d. Muy mala

A.2. El problema que consultamos se centra en:

- a. nosotros como pareja
- b. toda la familia
- c. en mi cónyuge
- d. mí
- e. mi familia de origen
- f. la familia de origen de mi cónyuge

A.3. Lo que yo espero de "Stirpe" es:

- a. Que nos ayuden a solucionar la situación
- b. Que nos solucionen todos
- c. No espero nada

A.4. La invitación a que acudamos los dos juntos a la consulta y la terapia

- a. Me ha parecido la mejor forma de abordar la situación.
- b. Me sorprende agradablemente
- c. Me produce curiosidad
- d. La acepto sin plantearme ningún problema
- e. Me deja indiferente
- f. Me sorprende negativamente y la rechazo

A.5. Antes de venir a "Stirpe", pienso que la raíz de nuestros problemas está:

- a. En nosotros como pareja
- b. En mi cónyuge
- c. En mí
- d. Sólo en quien aparece como "paciente"
- e. Fuera de nosotros
- f. En:

A.6. Si quiere añadir algo sobre la situación matrimonial, puede hacerlo a continuación.

Firma:

2.2. CUESTIONARIOS S-TF y S-TP

Hemos confeccionado estos dos Cuestionarios para evaluar la "actitud sistémica" que tiene cada miembro del sistema ante la consulta que formulan. Al contestar cada uno por su cuenta podemos tener una información preciosa de cara a determinar quiénes van a estar más inclinados a colaborar con los terapeutas y quiénes van a poner todo su empeño en enfocar todo el problema como el resultado lineal de conflictos o mecanismos intrapsíquicos del que aparece como "paciente".

2.2.1. CUESTIONARIO S-TF

Familia: Ref.:

Respuestas de:
Agradeceremos que antes de ser recibidos en nuestra consulta, nos responda, sin ponerse de acuerdo con los demás, las cuestiones siguientes:

(Responda SI o NO a cada una de las preguntas)

- S. 1. Pienso que la situación que vamos a consultar es sólo de
y solamente hay que actuar sobre él/ella:
- S. 2. Pienso que la situación tiene **algo** que ver con toda nuestra familia:
- S. 3. Pienso que la situación tiene **algo** que ver con la escuela/colegio/trabajo
y hay que intervenir también en ese plano:
- S. 4. Pienso que **todo** lo que nos preocupa es del ambiente familiar y hay
que actuar **sobre todos** por igual:
- S. 5. Pienso que **todo** es de tipo escolar/laboral y hay que actuar sobre la
escuela/colegio/trabajo:

Firma

2.2.2. CUESTIONARIO S-TP

Matrimonio: Ref.:

Respuestas de:
Fecha:
Agradeceremos que antes de ser recibidos en consulta, cada uno de Vdes. responda, separadamente, a las siguientes cuestiones:

(Responda SI o NO a continuación de cada pregunta)

- S. 1. Pienso que la situación que vamos a consultar es sólo de mi cónyuge
y solamente hay que actuar sobre él/ella:
- S. 2. Pienso que la situación tiene **algo** que ver con nuestro matrimonio:
- S. 3. Pienso que la situación tiene **algo** que ver con agentes externos a
nosotros y hay que actuar sobre ellos:
- S. 4. Pienso que **todo** es de nuestro matrimonio y hay que actuar en ese
plano:
- S. 5. Pienso que **todo** es ajeno a nosotros y es ahí donde hay que
actuar: (Señale dónde hay que actuar: (.....)).

Firma:

2.3. F.E.S. ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA. (Moss y Moss, 1984)

El Manual editado por TEA (1984) la presenta como el instrumento adecuado para "apreciar las características socio-ambientales de todo tipo de familia". Ya que "evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica". La escala consta de 90 elementos agrupados en 10 subescalas que definen las tres dimensiones indicadas.

1. Las relaciones evalúan el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Comprende las subescalas de **Cohesión (CO)**, **Expresividad (EX)** y **Conflicto (CT)**.
2. El desarrollo evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común. Comprende las subescalas de **Autonomía (AU)**, **Actuación (AC)**, **Intelectual-Cultural (IC)**, **Social-Recreativo (SR)** y **Moralidad-Religiosidad (MR)**.
3. La estabilidad nos da la información necesaria acerca de la estructura y organización de la familia, así como el grado de control que se ejerce en la familia. Las subescalas que la integran son las de **Organización (OR)** y **Control (CN)**.

El perfil que nos da esta Escala proporciona una visión bastante exacta de los puntos en los que el terapeuta ha de centrar su trabajo para incrementar algunos aspectos y para reducir otros, todo ello en función de la situación de cada subescala dentro de una distribución de puntuaciones en torno a las puntuaciones medias según los baremos que TEA ha establecido para la población española.

En los problemas de pareja puede ser válido para evaluar el Clima de la Familia actual (contestado sobre la familia constituida por la pareja) y compararlo con el Clima de la Familia de Origen de cada cónyuge. De este modo se detectan las posibles raíces de los conflictos actuales mediante la observación de las semejanzas y divergencias de cuanto ha recibido cada uno en su contexto familiar de origen.

24. ESCALA DE AJUSTE DIADICO (E.A.D. o D.A.S.) (Spaniers, 1976)

Es un Cuestionario de fácil autoaplicación que no está comercializada en España. Desde hace algunos años viene usándose en algunos grupos de trabajo clínico con parejas. Personalmente le debo su conocimiento a Alberto Espina (San Sebastián) y se ofrece como un instrumento muy útil para medir la cantidad y calidad de la relación marital a través de 4 subescalas:

1. **Consenso:** A través de 13 ítems valora el grado de acuerdo de la pareja en la toma de decisiones y otros aspectos de la vida familiar.
2. **Satisfacción:** Consta de 10 ítems y refleja el nivel de satisfacción que experimenta cada miembro en su relación de pareja.
3. **Expresión de afecto:** Mide dos aspectos de la interacción marital: la frecuencia, y descuidados en las relaciones sexuales y la frecuencia y descuidados en las demostraciones de afecto. A pesar de constar solamente de 4 ítems, la experiencia demuestra que refleja muy bien cuanto acontece en este nivel de la vida marital.
4. **Cohesión:** Mediante la información que recoge a través de 5 ítems, permite valorar la cohesión del matrimonio tomando como base la frecuencia y el número de actividades que realizan en común.

De la integración de las 4 subescalas puede obtenerse un índice de **Ajuste total** que resulta muy práctico para tener una visión bastante objetiva de la situación que atraviesa la pareja.

25. CUESTIONARIO SF-82. (Ríos-Stirpe, 1982)

Se trata de un Cuestionario autoaplicado de 100 ítems, actualmente no comercializado, a través del cual valoramos diversos aspectos de la dinámica familiar. Mientras seguimos recogiendo material para poder confeccionar criterios de evaluación y posibles escalas sobre la población española, lo utilizamos como fuente de información sobre la que apoyar las intervenciones terapéuticas. Somos conscientes de su excesiva amplitud y en este momento se están haciendo aplicaciones de una forma abreviada de 59 ítems para trabajos de Tesis Doctorales. Con ello se intenta facilitar la recogida de datos y la valoración de los mismos. Algunos contenidos de este Cuestionario son los relativos a actitud ante el cambio, alianzas, autonomía de los miembros, cohesión familiar, tipos y niveles de la comunicación en el interior del sistema, culpabilizaciones, mitos, poder, reglas, roles y atribuciones, subsistemas, valores y vínculos o lazos afectivos que existen en la familia.

Tiene 2 Cuestionarios complementarios: uno para parejas (**Cuestionario SF-82-Parejas**) y otro (**Cuestionario SF-82-Autoevaluación personal**) para evaluar el concepto de sí mismo que tiene el sujeto que va a ser tratado en terapia familiar o de pareja.

25.1. CUESTIONARIO SF-82-Parejas. (Ríos-Stirpe, 1982)

Consta de 11 ítems que recogen la información necesaria para evaluar los siguientes aspectos:

1. Unión ante las decisiones
2. Áreas percibidas como conflictivas
3. Tipo de comunicación marital
4. Nivel de la comunicación en la pareja
5. Tipología de pareja
6. Sexualidad: iniciativa, motivación, nivel de satisfacción y afectividad
7. Afectividad
8. Poder y áreas de poder de cada cónyuge

25.2. CUESTIONARIO SF-82 (Autoevaluación personal). (Ríos-Stirpe, 1982)

Mediante 40 frases a las que el sujeto deberá responder si se ve reflejado en ellas (p.ej.: "me considero una persona feliz", "vivo mejor que la media que me rodea", "no he tenido muchos problemas en mi vida") o completando algunas abiertas ("mis principales dificultades en la vida han estado centradas en los siguientes temas (señalar 3 por orden prioritario)", "mi enfermedad crónica/frecuente es...", "actualmente me están tratando por enfermedad (señalar cual)", se obtiene un perfil de cómo se percibe la persona. Su descripción y posible interpretación, da algunas pistas para destacar áreas en las que será conveniente incidir durante la terapia. Lo más importante es poder llegar a relacionar esta percepción con lo que se obtiene sobre el contexto configurador de la personalidad y como se aprecia a través de lo que haya respondido al Cuestionario SF-82 general, cuando se haga Terapia Familiar y al Cuestionario SF-82-Pareja cuando se inicie una Terapia de Pareja.
